

百病单穴针灸验方

李磊 编著

• 最简单的方法
• 往往是最有效的方法 •

上海中医学院出版社

百病单穴针灸验方

李 磊 编著

上海中医学院出版社

(沪)新登字 206 号

百病单穴针灸验方

李 磊 编著

上海中医学院出版社出版发行
(上海零陵路 530 号 邮政编码 200032)

新华书店上海发行所经销 常熟市新华印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 4.25 字数 86,000

1994 年 1 月第 1 版 1994 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—5 000

ISBN 7-81010-239-7/R · 233

定价: 4.40 元

内 容 提 要

本书突出了针灸疗法简单易学、奏效迅速的特点。以临床实用为目的,辑取了九十余种常见病症的针灸单穴治法。所选各方都是经过作者长期运用、临床证明确实有效者。依病列方,每方只取一穴,并对其如何取穴、具体操作以及注意事项等作了详细说明。本书以作者多年来的临床经验为基础,每种治疗方法后多列举古代针灸文献,特别是现代临床报道作为佐证。治法简明,易学易用,言之有据,验之有效。是一本不可多得的针灸临床经验著作。可供广大针灸临床医生和其他爱好针灸疗法的医务工作者参考。

前 言

针灸疗法一向以操作简单、见效迅速著称,而应用单穴治疗疾病应该是最基本的治法。

《内经》中针灸取穴多取阿是穴,即所谓“以痛为输(腧)”(《灵枢·经筋》)。或“以手疾按之,快然,乃刺之”(《灵枢·五邪》),或“切之坚痛,如筋者,灸之”(《素问·骨空论》)。这种方法,现在临床上仍在应用。在压痛点或反应点上取穴,其疗效往往超过选用其他腧穴。

“以痛为输”便是单穴治法的一种。

从穴位的发展来看,先有阿是穴,然后才有奇穴和经穴。奇穴、经穴除了比阿是穴多了具体的名称和固定的部位以外,其主治作用也常常是阿是穴的扩展和增加。但名称的给予、部位的确定和主治范围的扩大,并不说明穴位的相对特异性也有所改变。每一穴位通常只对某些脏腑器官的疾病起治疗作用。

不同的穴位有着不同的适应症,针灸不同的穴位便可以获得不同的疗效。穴位的主治功能和相对特异性,奠定了针灸腧穴学和治疗学的基础。而如何对众多的穴位进行取舍,自然就成了针灸临床的关键。

古人的针灸取穴是比较简单的。在流传下来的历代针灸

歌赋中，单穴独用占了很大的比重。虽然随着中医药物治疗的进步，针灸也出现了配穴处方，但繁复的针灸处方，实际上并不切合临床实用。况且，绝大多数针灸处方，都只不过是若干单穴的简单组合而已。

因此，对初学者来说，要想有效地治疗疾病，至少应该从应用单穴开始。

本书以临床实用为目的，辑取了作者对近百种常见病症的针灸简易治法。每方只取一穴。或受之于师，或证之于友，或悟之于心，均经过作者的有效验证。治法简明，易学易用。希望能为初学者提供临床上的参考。

最简单的方法往往是最有效的方法。

李 磊

一九九三年七月记于上海中医学院

编写说明

1. 本书以切求实用为目的。所选各针灸方均是经过作者长期运用,临床证明确实有效者。

2. 全书共列病症九十余种。病症名称系根据当前针灸临床实际,以现代医学病名为主,偶而采用中医病名。

3. 每种病症下简要叙述了该病症的概念、发病原因、主要临床表现和诊断要点。除必要者外,未一一列举中西医对应病名。

4. 强调针灸的简明治法。每种病症下列出针灸疗法的有效处方,多为一方,最多不超过三方。

5. 每方只取一穴。分别按取穴、定位、操作方法、注意事项、文献参考各条进行叙述。

6. 各穴的名称、定位,以国家技术监督局 1990 年 6 月 7 日发布,1991 年 1 月 1 日开始实施的《中华人民共和国国家标准·经穴部位》为准。

7. 操作方法中除经特别说明外,均采用毫针刺法。所用毫针为 28 号($\phi = 0.38\text{mm}$)1.5 寸(40mm)。

8. 注意事项是指在治疗本病症、本穴位时,针灸的一些有关事项。施行针灸疗法的一般注意事项未予列出。

9. 文献参考是指选用此穴位治疗该病症的古代文献依

据及他人在报刊上发表的类似治疗经验。见仁见智，与作者治法不尽相同，希读者注意。

10. 书后附有所用穴位图和常用针灸歌赋，以备参考。

目 录

前言

编写说明

各科病症验方

1. 高热	1
2. 昏厥	2
3. 休克	2
4. 中暑	4
5. 溺水	5
6. 流行性感冒	6
7. 细菌性痢疾	8
8. 疟疾	9
9. 流行性腮腺炎	10
10. 咳嗽	11
11. 支气管哮喘	13
12. 心绞痛	16
13. 心律失常	17

14. 高血压	18
15. 呕吐	19
16. 呃逆	21
17. 胃痛	22
18. 腹痛	24
19. 腹泻	26
20. 便秘	27
21. 胃下垂	29
22. 胆绞痛	29
23. 术后腹胀	31
24. 肾绞痛	31
25. 阳痿	32
26. 遗精	33
27. 眩晕	34
28. 失眠	35
29. 狂证	36
30. 癫痫	37
31. 瘰病	38
32. 梅核气	39
33. 晕动病	40
34. 头痛	41
35. 偏头痛	43
36. 面神经麻痹	44
37. 坐骨神经痛	45
38. 股外侧皮神经炎	46
39. 阑尾炎	47

40. 乳痈·····	48
41. 痔疮·····	49
42. 直肠脱垂·····	50
43. 荨麻疹·····	52
44. 湿疹·····	53
45. 带状疱疹·····	53
46. 丹毒·····	54
47. 神经性皮炎·····	55
48. 银屑病·····	56
49. 白癜风·····	57
50. 疣·····	58
51. 斑秃·····	59
52. 鸡眼·····	59
53. 冻疮·····	61
54. 颞下颌关节功能紊乱症·····	61
55. 落枕·····	62
56. 颈椎病·····	63
57. 颈肩痛·····	64
58. 肩背痛·····	66
59. 胸痛·····	67
60. 肋肋痛·····	68
61. 肋软骨炎·····	69
62. 肩关节周围炎·····	70
63. 岗上肌肌腱炎·····	71
64. 肱二头肌肌腱炎·····	72
65. 肱骨外上髁炎·····	73

66.	腱鞘囊肿	74
67.	桡骨茎突部狭窄性腱鞘炎	75
68.	急性腰肌扭伤	76
69.	第三腰椎横突综合征	78
70.	腰肌劳损	79
71.	梨状肌综合征	80
72.	髌下脂肪垫损伤	81
73.	足跟痛	81
74.	软组织损伤	83
75.	疼痛	85
76.	痛经	85
77.	胎位不正	86
78.	百日咳	88
79.	婴幼儿腹泻	89
80.	疳积	90
81.	遗尿	92
82.	近视	93
83.	目赤肿痛	94
84.	耳鸣	95
85.	鼻塞	96
86.	鼻衄	98
87.	咽喉肿痛	100
88.	急性扁桃体炎	101
89.	慢性咽炎	103
90.	牙痛	104
91.	舌强	105

附录

1. 本书所用穴位图·····	107
2. 常用针灸歌赋·····	110
(1) 四总穴歌 ·····	110
(2) 马丹阳天星十二穴主治杂病歌 ·····	110
(3) 通玄指要赋 ·····	113
(4) 百证赋 ·····	115
(5) 玉龙赋 ·····	117
(6) 胜玉歌 ·····	119

各科病症验方

1. 高 热

高热指体温升高达 39°C 以上,是临床上常见的急症之一。多由感染、过敏反应、变态反应等所引起。中医称之为“壮热”、“实热”、“大热”。常伴有肌肤灼热、出汗、口渴、喜饮、呼吸及心率加快、烦躁不安等全身症状,严重者则可出现意识障碍。

取穴 大椎

定位 在背上部,后正中线上,当第1胸椎棘突与第7颈椎棘突之间的凹陷处。坐位低头取穴(图6)。

操作方法 微向上斜刺,刺入约1寸深。得气后施以提插捻转手法,强刺激。留针10~15分钟。出针后,再用毫针或用三棱针散刺大椎穴周围,加拔火罐,出血量约3~5毫升。

注意事项 针刺时不宜过深,以免伤及脊髓。

文献参考

1. 《针灸甲乙经》:“伤寒热甚烦呕,大椎主之。”
2. 盛氏应用针刺大椎穴治疗急性热病共274例。用2寸毫针,直刺1~1.5寸。得气后施平补平泻手法,待针感下传时即停止行针。留针40分钟。针前体温最高的 40.5°C ,最低的

37.6℃,平均38.8℃。针刺后188例有不同程度退热。针后30分钟,降温最多为1.5℃,最少为0.2℃,平均为1.4℃。(盛灿若:大椎穴退热作用的初步介绍,浙江中医杂志,(3): 17,1964)

2. 昏 厥

昏厥是指以突然昏倒,不省人事,四肢厥冷为主症的一种病症。多由体质虚弱或情志变化所致。患者始觉疲乏无力,眼前昏黑,泛泛欲呕,继而突然昏倒,不省人事,面色苍白,汗出肢冷,脉搏细弱。昏厥一般时间较短,醒后无后遗症。本病属于中医“郁冒”、“昏仆”、“薄厥”、“尸厥”、“厥逆”的范畴。

取穴 内关

定位 在前臂掌面的下段,当曲泽与大陵的连线上,大陵(腕横纹)上2寸,掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间,约与外关相对。舒腕仰掌取穴(图8)。

操作方法 取双侧穴位。直刺1寸左右。强刺激,持续行针至苏醒为度。

文献参考 韩氏应用内关穴治疗昏厥33例。取单侧内关穴,60岁以上则取双侧。轻微捻转和震颤交替使用,不留针。除2例5分钟后苏醒外,其余病例均在1分钟左右苏醒。(韩祖濂:针刺内关治疗昏厥33例,浙江中医杂志,21(11):511,1980)

3. 休 克

休克是由感染、出血、脱水、心功能不全、过敏、严重创伤

等原因引起的以微循环血流障碍为特征的急性循环功能不全综合征。其病理生理特点为有效循环血量减少,重要器官血流灌注量不足,组织缺血、缺氧而造成代谢紊乱和细胞受损。主要临床表现为血压下降、面色苍白、四肢湿冷、脉搏细数、烦躁不安、反应迟钝、神志模糊、甚至昏迷。本病属中医“厥证”、“脱证”的范畴。

方 一

取穴 水沟(人中)

定位 在面部,当人中沟的上1/3与中1/3交点处。坐位或仰卧位取穴(图1)。

操作方法 向上斜刺,刺入约1寸左右。施以捻转提插手法,强刺激,持续行针至症状改善为止。

注意事项 本法可作为休克治疗的应急措施。

文献参考 张氏应用针刺水沟(人中)穴治疗1例一氧化碳中毒性休克和2例青霉素过敏性休克,进针后施捻转手法,强刺激。均取得一定疗效。(张逸松:针刺人中急救一氧化碳中毒及青霉素过敏性休克,上海中医药杂志,(1):36,1962)

方 二

取穴 关元

定位 在下腹部,前正中线上,当脐下3寸,曲骨穴上2寸。仰卧位取穴(图5)。

操作方法 用大艾炷直接在穴位上施灸,不计壮数,或采

用艾条灸,艾火与皮肤表面的距离以病人能够耐受为度。

注意事项 在休克早期艾灸关元的疗效较好,可作为休克治疗的应急措施。

文献参考 杨氏应用关元穴艾条灸治疗休克患者共30例,其中失血性休克7例,感染性休克23例。施灸15分钟,艾火与皮肤表面的距离以病人能够耐受为度。结果显效6例,有效16例,无效8例,有效率为73%。(杨日初:艾灸关元对休克患者血压和指温的影响,上海针灸杂志,(1):1,1985)

4. 中 暑

中暑多因在烈日之下或高温环境中长时间停留或工作所致。机体热平衡失调,机体代谢产热增加而散热困难,造成热量蓄积即可发生中暑。轻者可有体热、多汗、头昏、耳鸣、胸闷、心悸、口渴、恶心、四肢无力、脉细弱而快等现象,重者则可出现烦躁不安、神昏痉厥等症。根据病情的轻重和主要症候表现,中医有“伤暑”、“暑厥”、“暑风”等名称。

方 一

取穴 大椎

定位 在背上部,后正中线上,当第1胸椎棘突与第7颈椎棘突之间的凹陷处。坐位低头取穴(图6)。

操作方法 微向上斜刺,刺入约1寸深。得气后施以提插捻转手法,强刺激。留针10~15分钟。出针后,再用毫针或用三棱针散刺大椎穴周围,加拔火罐,出血量约3~5毫升。

注意事项

- (1) 针刺时不宜过深,以免伤及脊髓。
- (2) 本方适用于中暑轻症。

文献参考

- (1) 《针灸甲乙经》:“伤寒热甚烦呕,大椎主之。”
- (2) 盛氏应用针刺大椎治疗急性热病共274例。用2寸毫针,直刺1~1.5寸。得气后施平补平泻手法,待针感下传时即停止行针。留针40分钟。针前体温最高为40.5℃,最低为37.6℃,平均38.8℃。针刺后188例有不同程度退热。针后30分钟,降温最多为1.5℃,最少为0.2℃,平均为1.4℃。(盛灿若:大椎穴退热作用的初步介绍,浙江中医杂志,(3):17,1964)

方 二

取穴 水沟(人中)

定位 在面部,当人中沟的上1/3与中1/3交点处。坐位或仰卧位取穴(图1)。

操作方法 向上斜刺,刺入约1寸左右。施以提插捻转手法,强刺激,以患者泪出为度。

注意事项 本方适用于中暑重症。

文献参考 《针灸大成》:“中暑不省人事:人中、合谷、内庭、百会、中极、气海。”

5. 溺 水

溺水是指人体淹没于水中,呼吸道及肺部为水所堵塞而

引起窒息的状态。由于缺氧，造成体内血流动力学和血液生化改变，溺水患者均有不同程度的代谢性酸中毒。其临床表现则因窒息的轻重而有所不同，主要取决于溺水量的多寡和持续时间的长短，严重者可导致呼吸衰竭及心跳停止而死亡。

取穴 涌泉

定位 在足底部，卷足时足前部凹陷处，约当足底2、3趾趾缝纹头与足跟连线的前1/3与后1/3交点上(图13)。

操作方法 取双侧穴位。直刺约1寸，施以大幅度提插捻转手法，强刺激。留针20~30分钟。

注意事项

(1) 针刺前应首先清除患者口腔、鼻腔的污物，恢复呼吸道的通畅，并迅速倒出呼吸道及胃内积水。如呼吸或心跳已停止，则应首先或同时进行人工呼吸或心脏按摩。

(2) 此穴针刺时疼痛剧烈，感应较强。

文献参考

(1) 《寿世保元》：“治自缢气已脱，极重者只灸涌泉穴，男左女右，三壮即活。”

(2) 《回阳九针歌》：“哑门、劳宫、三阴交，涌泉、太溪、中脘接；环跳、三里、合谷并，此是回阳九针穴。”

6. 流行性感 冒

流行性感 冒是由流行性感 冒病毒引起的急性呼吸道传染病。其临床特点为突然发病，患者畏寒、高热、头痛、全身肌肉酸痛、乏力、食欲减退，并伴有鼻塞、流涕、咳嗽、咽痛等症状。

本病多发于冬春季节，常可在短时间内造成流行。属于中医“风温”、“冬温”、“春温”的范畴。

取穴 大椎

定位 在背上部，后正中线上，当第1胸椎棘突与第7颈椎棘突之间的凹陷处。坐位低头取穴(图6)。

操作方法 微向上斜刺，刺入约1寸深。得气后施以提插捻转，强刺激。留针10~15分钟。出针后，再用毫针或用三棱针散刺大椎穴周围，加拔火罐，出血量约3~5毫升。

注意事项

(1) 针刺时不宜过深，以免伤及脊髓。

(2) 本法适用于流感而全身症状较重者。如系轻症，可仅在患者大椎穴拔火罐，或施以艾条温和灸，时间5~10分钟，以局部有温热感为度。

(3) 普通感冒亦可参照本法治疗。

文献参考

(1) 《伤寒杂病论》：“太阳与少阳并病，颈项强痛，或眩冒，时如结胸，心下痞硬者，当刺大椎第一间。”

(2) 曹氏应用艾灸大椎穴治疗流行性感冒21例，均获显效。施以艾条温和灸，每次20分钟，或施以隔姜灸，每次3~5壮。每日2~3次。初起者灸1~2次便可控制，一般灸2~3日即可治愈。(曹仁和：流感独灸大椎穴治疗21例，江苏中医杂志，7(5)：33，1981)

(3) 郭氏应用大椎穴针刺拔罐治疗风寒感冒共73例。局部用三棱针点刺2~3下，然后加拔火罐，以溢血为度。一般治疗1次即愈，少数患者2~3次痊愈。(郭子光：大椎穴针刺拔罐

7. 细菌性痢疾

细菌性痢疾是由痢疾杆菌引起的急性肠道传染病。常见于夏秋季,多有不洁饮食史或菌痢患者接触史。起病急速,腹痛,腹泻,有明显里急后重感。大便初起为水样,后转为粘液脓血便,次数增多,每天可达数十次。伴有畏寒、发热、恶心、呕吐、食欲不振、全身不适等症状。严重者可出现高热、惊厥、昏迷、休克及呼吸衰竭。血白细胞总数和中性白细胞分类计数常增高。粪便镜检可发现大量脓细胞和红、白细胞,培养可获痢疾杆菌。

取穴 上巨虚

定位 在小腿前外侧,当犊鼻下 6 寸,距胫骨前缘 1 横指(中指)(图 10)。

操作方法 取双侧穴位。在上巨虚穴上下寻找压痛点,直刺约 2 寸深,得气后施以提插捻转,强刺激。留针 20~30 分钟。每日 1 次,5 次为 1 个疗程。

注意事项 亦可应用水针疗法。在压痛点处穴位注射阿托品 0.5 毫克、黄连素 20 毫克或 0.5% 普鲁卡因 2 毫升,每日 1 次,5 次为 1 个疗程。

文献参考 《针灸甲乙经》:“少腹痛,飧泄出糜,次指间热,若脉陷,寒热身痛,唇渴不干,汗出,毛发焦,脱肉少气,内有热,不欲动摇,泄脓血,腰引少腹痛,暴惊,狂言非常,巨虚上廉主之。”

8. 疟 疾

疟疾是人体感染疟原虫后所引起的传染病。发病多在夏秋季节。以周期性的寒战、高热、出汗为主要临床特征。多间隔24或48小时发作1次。发作间隙无症状。多次发作可出现贫血和脾脏肿大。血及骨髓涂片可找到疟原虫。本病属中医“疟证”范畴。

取穴 疟门

定位 在手背部,中指和无名指指缝之间,指掌关节前凹陷处,赤白肉际(图7)。

操作方法 取双侧穴位。患者半握拳,直刺约1寸深。得气后施以提插捻转手法,强刺激。留针30分钟。每日1次,3次为1个疗程。

注意事项

(1) 针刺时间以疟疾发作前1~2小时为宜,也可在发作时针刺。

(2) 在留针期间应每隔3~5分钟行针1次,并可适当延长留针时间。

(3) 本法对间日疟疗效较好。

文献参考

(1) 朱氏等应用针刺疟门穴治疗间日疟共270例。其中1次治愈者195例,占72.3%;2次治愈者58例,占21.5%;3次治愈者5例,占1.84%;4次治愈者1例,占0.37%;不明者10例,占3.7%;无效者1例,占0.37%。(朱复林等,针刺疟门穴

治疗和预防疟疾,江苏中医,(11):32,1961)

(2) 彭氏应用针刺疟门穴治疗间日疟共16例。均针刺1次即控制发作。(彭圆珍:针刺治疗间日疟,赤脚医生杂志,(6):32,1976)

9. 流行性腮腺炎

流行性腮腺炎俗称“痄腮”。是由腮腺炎病毒所引起的急性全身性病毒性传染病。以发热、腮腺的非化脓性肿胀、疼痛为主要特征,其他腺体和中枢神经系统也可同时受累。一般流行于冬春季节,儿童多见。成人发病,症状往往比儿童为重。

取穴 角孙

定位 在头侧部,当耳尖直上入发际处(图3)。

操作方法 取患侧穴位。剪去毛发,常规消毒后,用灯芯草蘸少许麻油点燃,迅速点按在穴位上,一触即起,以听到清脆的“啪”声为准。一般只灸1次,若肿势未退,可于次日再灸1次。

注意事项

(1) 点灸后穴位处可出现小水泡,注意不要抓破,可任其自行吸收。

(2) 如无灯芯草,亦可用火柴点灸。但刺激较强,灸后局部偶会出现焦痂,应注意防止感染。

(3) 亦可在角孙穴处用三棱针点刺出血。出血量不宜太多,3~5滴即可。

文献参考

(1) 胡氏等应用灯火灸角孙穴治疗腮腺炎共 334 例。结果痊愈 312 例(2 次治愈 85 例, 3 次治愈 165 例, 4 次治愈 62 例), 有效 5 例, 无效 17 例。(胡德华等: 灯火灸角孙穴治疗腮腺炎 334 例, 湖北中医杂志, (6): 49, 1986)

(2) 高氏应用火柴点灼角孙穴治疗流行性腮腺炎共 329 例。全部治愈。疗程 1~4 天, 平均 3 天左右。对其中 17 例伴有高热(39°C 以上)者均在治疗 24 小时内体温恢复正常。(高振群: 点灼角孙穴治疗流行性腮腺炎 329 例效果观察, 安徽中医学院学报, (4): 42, 1985)

10. 咳 嗽

咳嗽是一种将呼吸道的分泌物或异物排出体外的保护性反射动作, 也是呼吸系统疾病的常见症状。引起咳嗽的原因很多, 临床上多见于急、慢性支气管炎、肺炎、支气管扩张、上呼吸道感染等疾病。

方 一

取穴 鱼际

定位 在手掌侧面鱼际部的桡侧缘(赤白肉际), 当拇指掌指关节与腕掌关节中点的凹陷处, 约当第 1 掌骨中点桡侧(图 8)。

操作方法 取双侧穴位。直刺约 0.5~1 寸, 得气后施以提插捻转手法, 强刺激。留针 30 分钟。每日 1 次, 7 次为 1 个疗程。

注意事项

(1) 留针期间应每隔 3~5 分钟行针 1 次。

(2) 亦可应用水针疗法。在鱼际穴处穴位注射 0.5% 普鲁卡因 2 毫升,每周 1 次。

文献参考 邵氏应用针刺鱼际穴治疗咳嗽共 100 例,结果痊愈 56 例,其中 1 次治愈 30 例,2 次治愈 26 例,显效 43 例,无效 1 例。(邵亚萍:针刺鱼际穴治疗咳嗽 100 例,针灸学报,(1):34,1990)

方 二

取穴 肺俞

定位 在背上部,当身柱穴(第3与第4胸椎棘突之间凹陷部)的外侧 1.5 寸处。坐位或俯卧位取穴(图6)。

操作方法 取双侧穴位。向脊柱方向斜刺约 1 寸,得气后施以捻转手法,中刺激。留针 20~30 分钟。针后局部加拔火罐。每日或隔日 1 次,7 次为 1 个疗程。

注意事项

(1) 不可直刺,以防针尖刺入胸腔而造成气胸。

(2) 亦可应用水针疗法。在肺俞穴处穴位注射 0.5% 普鲁卡因 2 毫升,隔日 1 次。5 次为 1 疗程。

文献参考

(1) 《针灸甲乙经》:“肺气热,呼吸不得卧,咳上气呕沫,喘,气相追逐,胸满胁膺急,息难,……肺俞主之。”

(2) 张氏应用肺俞穴穴位注射鱼腥草注射液,治疗上感所致剧烈咳嗽共 55 例,取双侧穴位,每次注入鱼腥草注射液

1~2 毫升。每日1次,2~4 次为疗程。结果痊愈 31 例,显效16 例,好转8 例。一般治疗1~2个疗程即可显效。(张秀珍:鱼腥草穴位注射治疗上感所致剧烈咳嗽 55 例,广西中医药,(3): 43,1980)

11. 支气管哮喘

支气管哮喘(简称哮喘)是一种常见的支气管变态反应性疾病。常由各种不同抗原(如花粉、灰尘、兽毛、细菌、霉菌等)所引起。以支气管痉挛、粘膜水肿、分泌物增多而使支气管阻塞为病理特征。患者有胸闷、气急、哮喘、咳嗽和咳出粘液样痰等症状。往往反复急性发作,缓解期症状和体征可完全消失。本病属于中医的“哮证”、“喘证”等范畴。

方 一

取穴 天突

定位 在颈部,当前正中线上,胸骨上窝中央。仰头取穴(仰卧位或坐位)(图5)。

操作方法 用30号2寸毫针,先直刺 0.2~0.3 寸,然后沿胸骨柄后缘、气管前缘,缓慢向下刺入1寸左右。得气后施行捻转手法,中刺激。留针 30 分钟。

注意事项

(1) 不可直刺过深,以免伤及气管。亦不可向左右斜刺,以防刺伤肺尖。

(2) 本法主要用于哮喘发作期,可即刻缓解症状。

文献参考

(1) 《铜人腧穴针灸图经》：“天突：治咳嗽上气，胸中气噎，喉中状如水鸡声。”

(2) 刘氏应用针刺天突穴治疗哮喘2例，治疗1次后哮喘即愈。(刘双柱：天突一针哮喘平，河北中医，(3)：42，1985)

(3) 陈氏等应用天突穴穴位注射鱼腥草注射液或链霉素治疗哮喘共162例。用2毫升注射器，5~7号针头，迅速刺入皮下后，针尖转向下方，待得气后注入鱼腥草注射液2毫升或链霉素0.5克。结果治愈76例，好转78例，无效8例。总有效率95.1%。一般针刺1~3次即可取得满意疗效。(陈康明等：穴位注射治疗哮喘162例，湖南中医学院学报，(3)：9，1986)

方 二

取穴 鱼际

定位 在手掌侧面鱼际部的桡侧缘(赤白肉际)，当拇指掌指关节与腕掌关节的中点的凹陷处，约当第1掌骨中点桡侧(图8)。

操作方法 取双侧穴位。直刺约0.5~1寸。得气后施以提插捻转手法，强刺激。留针30分钟。留针期间每隔3~5分钟行针1次。

注意事项 本法亦可应用于哮喘缓解期。隔日1次，10次为1个疗程。

文献参考 刘氏应用针刺鱼际穴治疗支气管哮喘共200例，左右侧穴位交替使用，每日1次，10次为1个疗程。或在发作时针刺。结果基本痊愈37例，占18.5%；显效92例，占

16%；有效68例，占34%；无效3例，占1.5%；总有效率为98.5%。（刘泽光：针刺鱼际穴治疗支气管哮喘200例，中国针灸，(1)：4，1985）

方 三

取穴 四缝

定位 在两手第2~5指的掌面，指间关节横纹之中点处，一侧4穴(图8)。

操作方法 取双侧穴位。常规消毒后，用三棱针点刺，挤出少量黄白色粘液或出血。每周1次。5次为1个疗程。

注意事项

(1) 点刺应迅速、准确，术后可用消毒棉球在穴位上按压片刻。

(2) 点刺时以刺出黄色粘液为佳，如仅有出血，则疗效较差。

(3) 本法适用于小儿哮喘。

文献参考

(1) 翟氏应用点刺四缝穴治疗小儿哮喘37例，间隔3日或1周1次，3次为1个疗程。结果显效13例；好转21例；无效3例。（翟范：针刺四穴位治疗小儿哮喘，辽宁中医杂志，(2)：14，1981）

(2) 陈氏应用挑刺四缝穴治疗小儿哮喘共120例。经治疗1~2次获愈者70例，3~4次获愈者38例，无效12例（均未挑出粘液），治愈率达90%。（陈林才：挑四缝治疗小儿哮喘，江苏中医，(3)：22，1990）

12. 心 绞 痛

心绞痛是由于急剧的暂时性心肌缺血、缺氧所引起的临床综合征。多因体力活动、情绪激动、饱餐等而诱发。为胸骨后或左前胸的压榨性、压迫性疼痛或烧灼感,疼痛部位比较固定,并向左肩及左臂放射。时间大多持续3~5分钟,一般不超过半小时。休息或服用硝酸甘油可得到缓解。本病多为冠状动脉粥样硬化性心脏病的一个主要临床症状。属于中医“胸痹”、“真心痛”、“厥心痛”的范畴。

取穴 内关

定位 在前臂掌面的下段,当曲泽与大陵的连线上,大陵(腕横纹)上2寸,掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间,约与外关相对。舒腕仰掌取穴(图8)。

操作方法 取双侧穴位。略向上方斜刺,刺入1寸左右,得气后施以提插捻转,强刺激。一般即觉胸闷、心悸等症状有所减轻。可留针20~30分钟。

注意事项

- (1) 针刺时若能令针感上行至腋窝或胸部,则疗效较好。
- (2) 本法除了可以缓解心绞痛外,亦可用于改善冠心病的其他症状。

文献参考

- (1) 《千金要方》:“凡心实者,则心中暴痛;虚则心烦,惕然不能动,失智;内关主之。”
- (2) 赵氏等应用针刺内关穴治疗冠心病共36例。取双侧

内关穴,每日1次,10次为1个疗程。其中实证16例,治疗后胸闷、胸痛等主症全部消失;虚证20例,18例主症消失。其他如心功能、血流变、血脂等检查均有改善。(赵颖等:针刺内关穴治疗冠心病疗效分析及机理探讨,中国针灸,(3):15,1987)

(3) 鲍氏应用针刺内关穴治疗冠心病急性心肌梗塞共13例。其中显效5例,明显有效7例,有效1例。13例针前有胸痛,针后全部消失7例,6例转为轻度,胸痛的缓解率为100%。并可使由于胸闷痛所致的烦躁不宁转为安静状态。(鲍延熙:针刺内关穴对急性心肌梗塞的即刻疗效,中国针灸,(2):2,1981)

13. 心 律 失 常

心律失常是指心脏内冲动的起源或其传导发生异常,或顺序发生改变,引起心率过速、过缓或心律不规则。临床常见的心律失常有冲动起源失常的窦性心律不齐和异位性心律,以及冲动传导异常的心脏传导阻滞和预激症候群。患者的主要症状为心悸、胸闷、气急、头晕、乏力,偶有恶心、呕吐、心前区疼痛或晕厥。心律失常可见于心脏的多种器质性病变。属于中医“惊悸”、“怔忡”的范畴。

取穴 内关

定位 在前臂掌面的下段,当曲泽与大陵的连线上,大陵(腕横纹)上2寸,掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间,约与外关相对。舒腕仰掌取穴(图8)

操作方法 取双侧穴位。略向上方斜刺,刺入1寸左右,

得气后施以提插捻转,中刺激。留针 20~30 分钟。每日或隔日1次,10次为1个疗程。

注意事项

- (1) 在心律失常的发作期针刺可采用强刺激。
- (2) 本法对心脏传导阻滞以及慢性房颤疗效较差。

文献参考

(1) 《千金要方》:“凡心实者,则心中暴痛;虚则心烦,惕然不能动,失智;内关主之。”

(2) 孙氏应用针刺内关穴治疗各种心律失常共84例。其中痊愈(患者自觉症状消失,心脏听诊及心电图检查恢复正常)14例,占16.7%;显效(患者自觉症状基本消失,心脏听诊心电图检查明显改善)20例,占23.8%;好转(患者自觉症状减轻,心脏听诊及心电图检查有一定改善)44例,占52.3%;无效(患者自觉症状与心脏听诊及心电图检查无改善)6例,占7.2%;总有效率为92.8%。(孙步洲:针刺内关治疗心律失常84例,江苏中医,(1);28,1988)

14. 高 血 压

高血压是指在安静状态下动脉血压超过正常范围而言。血压测定收缩压超过21.3kPa (160毫米汞柱),舒张压超过12.6kPa (95毫米汞柱),两者有一项经核实即可诊断为高血压。本病为常见的慢性病,多伴有头痛、头胀、眩晕、耳鸣、胸闷、心悸、失眠、肢麻等症状。如血压骤然升高,出现剧烈头痛、恶心呕吐、心动过速、视力模糊、气喘气急、甚至昏迷抽搐等症状,称为高血压危象,则为危重之症。

取穴 曲池

定位 在肘部的桡侧，当尺泽穴与肱骨外上髁之间的中点处(肘关节屈曲成90度)(图7)。

操作方法 取双侧穴位。直刺约1~1.5寸。得气后施以捻转提插手手法，中刺激或强刺激。留针20~30分钟。

注意事项 本法适用于原发性高血压，一般针刺后血压可立即下降2.66kPa(20毫米汞柱)左右。

文献参考 熊氏应用针刺曲池穴治疗高血压共56例。取双侧穴位，向对侧少海穴透刺1.5~2寸深，每5~10分钟行针1次，留针1小时。每日1次，10次为1个疗程。结果显效40例，占71%；明显有效9例，占16%；有效5例，占9%；无效2例，占4%。治疗前平均血压190/115毫米汞柱，治疗后平均降至156/95毫米汞柱。(熊路虎：针刺治疗高血压疗效观察，上海针灸杂志，(2)；3，1984)

15. 呕 吐

呕吐是指胃内容物逆流出口腔的现象。以有声无物为呕，无声有物为吐。常伴有恶心、胸闷、腹痛、腹胀、食欲不振等症状，可见于多种疾病。在一般情况下呕吐是一种保护性反射动作，可使某些对胃有刺激性的物质经口吐出。但是严重的呕吐则可引起机体的水、电解质代谢紊乱，甚至造成休克。因此除了对症处理外，还须寻找病因，及予以诊断和治疗。

方 一

取穴 肩井

定位 在肩部,当大椎与肩峰端连线的中点处(图6)。

操作方法 取双侧穴位。直刺约1寸,得气后施以捻转手法,强刺激。留针20~30分钟。

注意事项

(1) 不可针刺过深,以防刺入胸腔,引起气胸。

(2) 孕妇禁针。

文献参考 陈氏应用肩井穴为主治疗各种呕吐共143例。结果痊愈126例,占88%;其中针后立即停止呕吐者43例,1次治愈者69例,2次治愈者45例,3次治愈者12例,一般针刺1~3次即可见效。(陈维扬:以肩井穴为主治疗呕吐临床疗效分析,江西中医药,(1):39,1981)

方 二

取穴 内关

定位 在前臂掌面的下段,当曲泽与大陵的连线中点,大陵(腕横纹)上2寸,掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间,约与外关相对。舒腕仰掌取穴(图8)。

操作方法 取双侧穴位。直刺约1寸,得气后施以提插捻转手法,强刺激。留针20~30分钟。

注意事项 本法适用于各种原因所致的呕吐,可即刻缓解症状。

文献参考

(1) 熊氏在饭后针刺内关穴治疗神经性呕吐共13例，均获痊愈。其中11例当时控制而未出现呕吐，其余2例在针后仅略感恶心。平均3天7次治愈，经随访半年以上无复发。(熊新安：针刺内关穴治疗神经性呕吐的时机，中医杂志，(11)：19，1981)

(2) 苏氏应用针刺内关穴治疗手术麻醉中恶心呕吐共67例。其中恶心呕吐于1分钟停止者36例，1~4分钟停止者21例，4~7分钟停止者6例，超过7分钟或以其他措施停止者4例。总有效率为94%。(苏心镜：针刺内关穴治疗麻醉中恶心呕吐67例，中国针灸，(4)：48，1988)

16. 呃 逆

呃逆俗称“打嗝”，古称“哕”，是指气逆上冲，喉间呃呃有声，声短而频，不能自止的病证。多见于胃神经官能症、膈肌痉挛、胃炎、胃扩张等疾病。本症如为偶然发作，大多病情轻微，可以不治自愈；若发于病中，持续不断，或反复发作，每为病势危重的征兆。

方 一

取穴 涌泉

定位 在足底部，卷足时足前部凹陷处，约当足底2、3趾趾缝纹头与足跟连线的前1/3与后1/3交点上(图13)。

操作方法 取双侧穴位。直刺约1寸，得气后施以提插捻

转手法,强刺激。留针20~30分钟。

文献参考 夏氏应用针刺涌泉穴治疗顽固性呃逆共12例。治疗1次控制者11例,2次控制者1例,其中个别病例有复发,用原法仍立即收效。(夏晓川:针刺治疗顽固性呃逆12例,湖北中医杂志,(5):48,1989)

方 二

取穴 中魁

定位 在中指背侧近端指间关节的中点处(图7)。

操作方法 取双侧穴位。于中魁穴上涂少许凡士林,然后施以麦粒灸,连续灸5壮,每日1次。3次为1个疗程。

注意事项

(1) 若灸疮有渗液,可涂以龙胆紫药水,并用消毒纱布覆盖。

(2) 亦可采用针刺疗法,取双侧穴位,直刺约0.2~0.3寸,强刺激。每日1次,3次为一个疗程。

文献参考 华氏应用艾灸中魁穴治疗呃逆共5例,均灸2~3次获愈,其中1例13天后复发,再灸仍获效。(华延令:灸中魁穴治疗呃逆5例的体会,上海针灸杂志,(1):18,1984)

17. 胃 痛

胃痛又称胃脘痛,以上腹胃脘部近心窝处经常发生疼痛为主症。多见于急、慢性胃炎,胃、十二指肠溃疡,胃痉挛、胃神经官能症及其他消化道疾病。

方 一

取穴 中脘

定位 在上腹部,前正中线上,当脐上4寸。仰卧位取穴(图5)。

操作方法 医生左手拇指切按在穴位上,右手持针,紧靠指甲快速刺入皮下,然后手指用力徐徐进针,直刺约1寸。得气后施以捻转手法,中刺激。留针20~30分钟。留针期间加用温针灸,针后加拔火罐。

注意事项 勿针刺过深,以免刺伤内脏。

文献参考 《针灸甲乙经》:“胃胀者,腹满,胃脘痛,鼻闻焦臭,妨于食,大便难,中脘主之。”

方 二

取穴 足三里

定位 在小腿前外侧面的上部,犊鼻穴下3寸,距胫骨前缘1横指(中指)(图10)。

操作方法 取双侧穴位。在足三里穴上下寻找压痛点,直刺约2寸深,得气后施以提插捻转,强刺激。留针30分钟。

注意事项 亦可应用水针疗法。在压痛点处穴位注射阿托品0.5毫克或0.5%普鲁卡因2毫升,每周1次。

文献参考

(1) 《灵枢·邪气脏腑病形》:“胃病者,胃腹胀,胃脘当心而痛,上支两胁,膈咽不通,饮食不下,取之三里也。”

(2) 宁氏应用足三里穴穴位注射安痛定治疗剧烈胃痛共20例,均获得满意疗效。取双侧穴位,每侧穴位注射安痛定2毫升。一般于注射后3分钟止痛。(宁永礼:足三里穴安痛定注射治疗剧烈胃痛20例,哈尔滨中医,(10):78,1960)

18. 腹 痛

腹痛是临床最常见的症状之一。可由腹腔内脏器的器质性或功能性病变所致,也可由腹外器官的病变或全身感染、内分泌与代谢紊乱、过敏、血液病等全身疾病而引起。

方 一

取穴 阿是穴

定位 背部脊柱两侧。

操作方法 在背部脊柱两侧寻找压痛点,压痛点往往位于相应夹脊穴或背俞穴处。向内侧斜刺约1~2寸,得气后施以提插捻转手法,强刺激。留针20~30分钟。

注意事项 必须严格掌握针刺的方向和深度,不可针刺过深,以免伤及重要脏器。

文献参考 薛氏应用背部压痛点划割后加拔火罐治疗腹痛486例,结果痊愈(施用本法后病人腹痛消失,无需用任何解痉止痛药)414例,占85.2%;显效(施用本法后腹痛明显减轻,但仍未消失,尚须辅以解痉药)64例,占13.2%;无需(施用本法后腹痛未减轻,须改用其他疗法)8例,占1.6%。(薛继光:背部压痛点划割加火罐治疗腹痛486例,中国针灸,

(4):46,1989)

方 三

取穴 神阙

定位 在腹中部,脐中央。仰卧位取穴(图5)。

操作方法 采用隔盐灸。将食盐研细,填满脐部。切取厚约5毫米的生姜1片,中心处用针穿刺数孔,置于脐上,上面再放大艾炷,点燃施灸。灸5~10壮。

注意事项 注意勿烫伤皮肤。灸治过程中如感觉过热,可填加食盐。

文献参考 魏氏应用隔盐灸神阙穴治疗重症腹痛共50例。均治疗1~2次。其中痊愈42例,占84%,明显好转8例,占16%。(魏正健:隔盐灸神阙治疗重症腹痛50例,浙江中医杂志,17(8):364,1982)

方 三

取穴 足三里

定位 在小腿前外侧面的上部,犊鼻穴下3寸,距胫骨前缘1横指(中指)(图10)。

操作方法 取双侧穴位。在足三里穴上下寻找压痛点,直刺约2寸深,得气后施以提插捻转,强刺激。留针30分钟。

注意事项 亦可应用水针疗法。在压痛点处穴位注射阿托品0.5毫克或0.5%普鲁卡因2毫升。

文献参考 高氏等应用小剂量维生素K₃穴位注射足三

里穴治疗腹痛共76例,均经治疗1次获效。除1例止痛时间为25分钟外,其余病例止痛时间均在20分钟之内。(高景波等:小剂量维生素K₂穴位注射治疗腹痛76例的观察,中西医结合杂志,(9):562,1988)

19. 腹 泻

腹泻是临床上一种常见的症状。主要指肠蠕动增快而引起排便次数增多,粪便稀薄或完谷不化,甚至泻出如水样而言。可伴有腹胀、腹痛、恶心、呕吐、食欲不振、发热等全身症状,一般无里急后重,粪便不夹杂脓血。引起腹泻的病因很多,临床常根据其病程长短而分为急性腹泻与慢性腹泻两类。

(1) 急性腹泻

取穴 足三里

定位 在小腿前外侧面的上部,犊鼻穴下3寸,距胫骨前缘1横指(中指)(图10)。

操作方法 取双侧穴位。在足三里穴上下寻找压痛点,直刺约2寸深,得气后施以提插捻转,强刺激。留针20~30分钟。每日1次,5次为1个疗程。

注意事项 亦可应用水针疗法。在压痛点处穴位注射阿托品0.5毫克或0.5%普鲁卡因2毫升,每日1次。

文献参考

徐氏应用维生素B₁穴位注射足三里穴治疗泄泻共28例,

均获痊愈。取维生素B₁100毫克,注入单侧或双侧足三里穴,每日1次。其中注射1次痊愈者8例,2次痊愈者15例,3次痊愈者5例。(徐淑清:维生素B₁足三里穴位注射治疗泄泻28例,湖北中医杂志,(1):31,1985)

(2) 慢性腹泻

取穴 督脉及膀胱经背部穴位

定位 在背部,后正中线及左右旁开1.5寸和3寸侧线上,大椎穴水平线与腰俞穴水平线之间。

操作方法 沿项背腰骶部的督脉和两侧膀胱经,用皮肤针叩刺,轻刺激。以局部皮肤潮红为度。然后沿膀胱经由上至下加拔火罐。隔日1次,10次为1个疗程。

文献参考 熊氏应用沿膀胱经两侧脏腑腧穴拔走罐治疗五更泻共37例。痊愈26例,有效8例,无效3例。(熊路虎:沿膀胱经两侧脏腑腧穴拔走罐治疗五更泻37例,中国针灸,4(3):9,1984)

20. 便秘

肠内容物在肠内运行迟缓,排便次数减少,粪质坚硬,排便困难者,称为便秘。偶可伴有腹痛、腹胀、恶心、呕吐等其他症状。多见于各种急、慢性疾病中。便秘是体力活动少或长期卧床患者的常见合并症。其特异病因则包括结肠或直肠病变、体内代谢机能减退和神经官能症等。便秘中最常见的是习惯性便秘、老年性便秘以及饮食习惯和生活习惯改变所引

起的便秘,某些药物亦有致便秘作用。

(1) 习惯性便秘

取穴 支沟

定位 在前臂背侧,当阳池与肘间的连线上,阳池穴上3寸处,尺骨与桡骨之间(图7)。

操作方法 取双侧穴位。直刺约1寸深,得气后施以提插捻转手法,中刺激。留针30分钟。每日1次,10次为1个疗程。

文献参考 马氏应用针刺支沟穴治疗便秘共4例,均针刺1次后大便通畅。(马新风:针刺支沟治疗便秘,浙江中医杂志,(4):163,1990)

(2) 老年性便秘

取穴 天枢

定位 在中腹部,距脐2寸,即神阙穴外2寸处(图5)。

操作方法 用30号2寸毫针,直刺约1~1.5寸深。得气后施以捻转手法,中刺激。留针30分钟。留针期间加用温针灸。起针后局部加拔火罐。每日1次,10次为1个疗程。

文献参考 姜氏应用天枢穴温针灸治疗老年习惯性便秘共33例。其中27例痊愈(大便通畅,且随访半年以上无复发),4例有效(治疗过程中大便通畅,治疗后又复发),2例无效(治疗过程中大便通畅不超过3天)。(姜旭强:天枢穴温针灸治疗老年习惯性便秘33例,浙江中医杂志,(8):372,1989)

21. 胃 下 垂

胃下垂是指胃的位置下移而言。常见于体质瘦弱、营养不良与多产妇女。轻者多无症状,重者则主要表现为腹胀,饭后加重,平卧减轻。可伴有腹痛、恶心、嗝气、食欲不振、腹泻、便秘等消化系统症状,或眩晕、乏力、心悸、失眠等全身症状。上腹可扪及强烈的腹主动脉搏动,有时伴有肝下垂、肾下垂、子宫下垂等其他内脏下垂的体征。胃肠钡餐造影可见胃张力减弱,胃小弯弧线最低点在髂嵴连线以下。

取穴 中脘

定位 在上腹部,前正中线上,当脐上4寸。仰卧位取穴(图5)。

操作方法 医生左手拇指切按在穴位上,右手持针,紧靠指甲用力徐徐刺入,直刺约1寸。得气后施以捻转手法,中刺激,并将针轻轻上提。留针20~30分钟。留针期间加用温针灸,以局部温热为度。每日或隔日1次,7次为1个疗程。

注意事项 勿针刺过深,以免刺伤内脏。

文献参考 《循经考穴编》:“中脘:主一切脾胃之疾。”

22. 胆 绞 痛

胆绞痛是指以胆囊绞痛为主症的综合症候群,属于急腹症的范畴。多因胆囊结石、胆管结石、胆道蛔虫或胆囊急性炎症所引起。患者突发右上腹持续性疼痛或绞痛,呈阵发性

加剧,并向右肩背部放射。常伴有恶心、呕吐和发热。右肋下胆囊区有压痛及腹肌紧张,深吸气时有触痛反应(莫非氏征阳性)。血白细胞总数常增高。

方 一

取穴 阿是穴

定位 背部脊柱两侧压痛点。

操作方法 在背部寻找反应点,一般在第7~10胸椎棘突两侧夹脊穴处多有压痛点或阳性反应物。在反应点上针刺,向内侧斜刺约1寸。得气后施以大幅度提插捻转手法,强刺激。痛止后留针15~20分钟。针后加拔火罐。

注意事项 反应点多位于胸椎右侧,针刺后一般疼痛可即刻缓解。如疗效不显,可加取上下两椎的夹脊穴或胸椎左侧的对应点。

方 二

取穴 胆囊

定位 在小腿前外侧上部,当腓骨头前下方凹陷处(阳陵泉)直下2寸(图10)。

操作方法 取双侧穴位。在胆囊穴上下寻找压痛点,压痛最明显处是穴。直刺约1~2寸,得气后施以大幅度提插捻转手法,强刺激。留针20~30分钟,留针期间每隔3~5分钟行针1次。

注意事项 针刺手法宜强,一般可即刻缓解症状。

23. 术 后 腹 胀

术后腹胀多因腹部手术后胃肠平滑肌麻痹所致。患者腹胀明显,腹部柔软,肠鸣音减弱或消失。可伴有恶心、呕吐、便秘和腹部非局限性轻压痛。X线检查可见大、小肠,甚至直肠内有膨胀积气的肠袢。

取穴 足三里

定位 在小腿前外侧面的上部,犊鼻穴下3寸,距胫骨前缘1横指(中指)(图10)。

操作方法 取双侧穴位。在足三里穴上下寻找压痛点,直刺约2寸深,得气后施以提插捻转,强刺激。留针30分钟。

注意事项 亦可应用水针疗法,在压痛点处穴位注射新斯的明0.5毫克。

24. 肾 绞 痛

肾绞痛多因肾和输尿管结石而引起。常突然发生,表现为腰部钝痛和阵发性剧烈绞痛,持续数分钟或数小时不等。可放射至背部、下腹部、外阴部及大腿内侧,同时伴有恶心、呕吐、出冷汗等症状。肉眼可见血尿,患侧肾区有压痛和叩击痛。

方 一

取穴 阿是穴

定位 腰背部脊柱两侧压痛点。

操作方法 在腰背部寻找压痛点，一般压痛点在第11胸椎至第3腰椎棘突两侧夹脊穴或背俞穴处。在压痛点上针刺，向内侧斜刺约1寸。得气后施以大幅度提插捻转手法，强刺激。留针时间以痛止为度。针后加拔火罐。

注意事项 留针期间应每隔3~5分钟行针1次。

方 二

取穴 太溪

定位 在足内侧，内踝后方，当内踝尖与跟腱之间的凹陷处(图12)。

操作方法 取双侧穴位。在太溪穴处寻找压痛点。以压痛最明显处是穴，直刺约1寸，得气后施以提插捻转手法，强刺激。留针20~30分钟。

文献参考 王氏应用针刺太溪穴治疗尿石所致绞痛共23例。经针刺1~2次疼痛基本消失者18例，明显减轻者5例，总有效率100%。(王志义：针刺治疗尿石所致绞痛23例疗效观察，中国针灸，(5)：21，1986)

25. 阳 痿

阳痿是指青壮年男子虽有性欲，但阴茎不能勃起或勃而不坚，不能进行正常性交的病证。患者常伴有头晕目眩、精神不振、体倦乏力、腰膝酸软、失眠多梦等全身症状。生殖器发育和第二性征多无异常。本病属于现代医学中男性性功能障碍

碍的范畴。

取穴 关元

定位 在腹下部，前正中线上，当脐下3寸，曲骨穴上2寸。仰卧位取穴(图5)。

操作方法 医生左手拇指切按在穴位上，右手持针，紧靠指甲用力徐徐刺入，直刺约1寸。得气后施以捻转手法，中刺激。留针20~30分钟，留针期间加用温针灸。每日或隔日1次，10次为1个疗程。

注意事项 快速刺入皮下后，进针速度宜慢，边进针手指边向下用力。得气后，将针单方向捻转并微微上提，使下腹部有麻胀感或向前阴放射。

文献参考 王氏应用艾灸关元穴治疗阳痿共12例。采用中等艾炷直接灸，每次100~200壮，每周1次，3次为1个疗程。结果痊愈7例，显效3例，有效2例。(王风仪：艾灸关元穴治疗阳痿12例报告，中国针灸，(1)：42，1983)

26. 遗 精

遗精是指不因性交而排精的病证。有梦遗精称“梦遗”，无梦或在清醒状态下遗精称“滑遗”。一般成年未婚男子每月遗精1~2次，或每周遗精1次均属正常。若遗精频繁，同时伴有头晕耳鸣、精神萎靡、疲倦乏力、腰膝酸软等全身症状则为病态。本病属于现代医学中男性性功能障碍的范畴。

取穴 关元

定位 在腹下部，前正中线上，当脐下3寸，曲骨穴上

2寸。仰卧位取穴(图5)。

操作方法 医生左手拇指切按在穴位上,右手持针,紧靠指甲用力徐徐刺入,直刺约1寸。得气后施以捻转手法,中刺激。留针20~30分钟,留针期间加用温针灸。每日或隔日1次,10次为1个疗程。

注意事项 快速刺入皮下后,进针速度宜慢,边进针手指边向下用力。得气后,将针单方向捻转并微微上提,使下腹部有麻胀感或向前阴放射。

文献参考 《医学入门》:“关元:主诸虚损,及老人泄泻,遗精,白浊,令人生子。”

27. 眩 晕

眩,是指眼花;晕,是指头晕。眩晕是临床上常见的一种症状。轻者发作短暂,闭目即止;重者如乘舟车,自觉旋转不定,站立不稳。常伴有恶心、呕吐、出汗等症状。多见于现代医学的高血压、脑动脉硬化、贫血、颈椎病、神经衰弱、内耳性眩晕等病症。

方 一

取穴 四神聪

定位 在头顶部,百会穴之前、后、左、右各1寸处。共4穴(图2)。

操作方法 四穴针入后,分别向百会穴透刺。得气后施以快速捻转手法,强刺激,以患者感觉头顶部胀重为度。留针

20~30分钟。每日或隔日1次,10次为1个疗程。

注意事项 起针后必须用消毒干棉球按压针孔片刻,以防出血。

文献参考 《针灸资生经》:“神聪四穴,在百会四面各一寸。理头风目眩,狂乱风痫。”

方 二

取穴 风池

定位 在项部,枕骨之下,胸锁乳突肌与斜方肌上端之间的凹陷处,风府穴的外侧。重按时鼻腔有酸胀感(图6)。

操作方法 取双侧穴位。向对侧眼球方向刺入1~1.5寸。得气后施以捻转手法,强刺激,使针感传至侧头部。留针20~30分钟。每日或隔日1次,10次为1个疗程。

注意事项 针刺时针尖不可偏向内侧,以免针入椎管而损伤延髓。

文献参考 《通玄指要赋》:“头晕目眩,要觅于风池。”

28. 失 眠

失眠是指不易入睡或寐后易醒,甚则终夜不眠而言。多伴有头晕、头痛、神疲、乏力、心悸、多汗、食欲不振、记忆力减退等全身症状。常见于神经衰弱、神经官能症、更年期综合征、贫血、高血压等病症。

取穴 安眠

定位 翳风(平耳垂下方的凹陷中)与风池(胸锁乳突肌与斜方肌的凹陷中,后发际上1寸)连线的中点(图3)。

操作方法 取双侧穴位。直刺1寸左右,得气后施以捻转手法,使针感达半边头部。每日1次或隔日1次,10次为1个疗程。

注意事项

(1) 针刺手法应以捻转为主,不要作大幅度提插动作。

(2) 不宜针刺过深,以防刺入枕骨大孔而损伤延髓。

文献参考 王氏等应用针刺安眠穴治疗失眠共45例,均获满意疗效,一般3~5次即可痊愈。(王宏山等:安眠穴的临床应用和机理探讨,河南中医,(2):36,1982)

29. 狂 证

狂证是精神失常的病证。多发于青壮年。以性情烦躁、刚暴易怒、狂言妄语、不避亲疏、毁物伤人、力逾寻常等为特征。属于现代医学中精神分裂症、躁狂性精神病、癔病等精神疾病的范畴。

取穴 水沟(人中)

定位 在面部,当人中沟的上1/3与中1/3交点处。坐位或仰卧位取穴(图1)。

操作方法 向上斜刺,刺入约1寸左右。施以提插捻转手法,强刺激,以患者泪出为度。

文献参考

(1) 《铜人输穴针灸图经》:“水沟:治……失笑无时,癲痫,语不识尊卑,乍喜乍哭,……”

(2) 陈氏应用深刺人中穴治疗狂证，向上斜刺约3寸深，强刺激，一般10分钟内即可控制症状。(陈梅生：深刺人中抑“狂”，浙江中医药，(5):24,1977)

30. 癲 病

癲病是一种常见的神经症状，以脑部兴奋性过高的神经元异常放电而引起暂时性突发性大脑功能失调为主要特征。可有意识障碍、肢体抽搐、感觉、精神、行为或植物神经功能异常。常反复发作，发作间歇期无任何不适。根据发作时的表现，主要可分为大发作、小发作、局限性发作和精神运动性发作，大多具有间歇性、短时性和刻板性的共同特点。脑电图检查可帮助诊断。

方 一

取穴 四神聪

定位 在头顶部，百会穴之前、后、左、右各1寸处，共4穴(图2)。

操作方法 四穴针入后，分别向百会穴透刺。得气后施以快速捻转手法，强刺激，以患者感觉头顶部胀重为度。留针20~30分钟。隔日1次，10次为1个疗程。

注意事项 起针后必须用消毒干棉球按压针孔片刻，以防出血。

文献参考 某针灸科应用单刺四神聪穴治疗癲病共3例，均获治愈。一般针刺1次后症状即有好转。针刺次数最少者

5次,最多者20余次。经随访半年至2年,均未见复发。(连云港市新浦人民医院针灸科:单刺四神聪穴治疗癫痫病3例报告,江苏中医,(12):22,1964)

方 二

取穴 腰奇

定位 在骶部,当尾骨端直上2寸,骶角之间凹陷中(图6)。

操作方法 向上平刺1.5~2寸,得气后施以捻转手法,中刺激。留针20~30分钟。隔日1次,10次为1个疗程。

文献参考 魏氏应用针刺腰奇穴治疗癫痫共32例。癫痫停发,半年至3年随访未再犯者为痊愈,计22例;癫痫基本停发,但半年或1年出现1次轻微发作者为显效,计6例;治疗前后无明显变化者为无效,计4例。总有效率达87.5%。(魏翼:腰奇穴在临床之应用,陕西中医,(8):381,1986)

31. 癔 病

癔病,又名歇斯底里。患者以女性多见。常在精神受刺激后突然发病,呈阵发性发作,历时数分钟至数天(偶达数周)而逐渐恢复。临床症状多变,可分为精神障碍和躯体机能障碍两大类。精神障碍主要表现为情感暴发,如哭笑无常、说唱谩骂、手舞足蹈、捶胸顿足等,或出现昏厥、木僵、痴呆、朦胧和精神病状态等症状。躯体机能障碍则多表现为瘫痪、失音、失明、耳聋、痉挛、感觉障碍以及植物神经与内脏功能障碍等。经

检查不能发现相应器官的器质性病变。本病属于中医“厥证”、“郁证”、“脏躁”等证的范畴。

取穴 涌泉

定位 在足底部,卷足时足前部凹陷处,约当足底2、3趾趾缝纹头与足跟连线的前1/3与后1/3交点上(图13)。

操作方法 取双侧穴位。直刺约1寸,得气后施以大幅度提插捻转,强刺激。留针20~30分钟。

注意事项

(1) 治疗前须首先获取病人对医生的信任,使病人对针刺具有信心,否则疗效欠佳。

(2) 施行针刺时应配合语言暗示,可提高疗效。

文献参考

(1) 肖氏应用针刺涌泉穴治疗癔症共50例。针刺1次即愈者49例,1例无效。(肖仁鹤:毫针刺涌泉治疗癔症50例,湖北中医杂志,(5):39,1987)

(2) 徐氏应用圆利针针刺涌泉穴治疗癔病性失语共68例。其中针刺1次痊愈者66例;1例针刺当时能发单音词,但拒绝继续针刺;1例经针刺5次无效。有效率达98.5%。(刘更:针刺涌泉穴治疗不语症68例,中医杂志,(2):22,1981)

32. 梅 核 气

梅核气是指咽喉中常有异物感。大如梅核,时时梗阻不适,吐之不出,吞之不下,但饮食吞咽并无困难。其症状时轻时重,每随情志波动而变化。本病常伴有精神抑郁、多疑善虑、

胸胁胀满、食欲减退、月经不调等其他症状,女性患者多见,属于现代医学中咽部神经官能症、癔病、咽部异感症的范畴。

取穴 阿是穴

定位 咽后壁局部。

操作方法 患者坐位,使头部固定。医者一手用压舌板压住患者舌头,一手持三棱针点刺咽后壁局部5~10下,嘱患者吐出血性分泌物,然后用凉开水漱口。隔日1次,7次为1个疗程。

注意事项

(1) 点刺应手法轻快,深浅适度。

(2) 注意防止感染,有条件时可用复方硼砂溶液或其他消毒液漱口。

文献参考 周氏应用咽后壁点刺放血为主治疗咽异感症180例。每日或隔日1次,7次为1个疗程。结果显效(咽异物感消失,慢性咽炎咽部检查恢复正常或明显减轻)93例,有效(咽异物感减轻,慢性咽炎咽部检查仍有异常)64例,无效(治疗2个疗程,症状无明显减轻)23例,总有效率为88%。疗程最短2次,最长2个疗程。(周景伟:咽后壁点刺放血疗法为主治疗咽异感症180例,上海中医药杂志,(9):27,1989)

33. 晕 动 病

晕动病是指人在乘坐某种交通工具旅行时,因被动运动刺激前庭感受器而引起的症候群。不论乘坐汽车、火车、轮船、飞机或其他交通工具均可发生。主要表现为恶心、呕吐、

面色苍白、出冷汗及明显的精神症状,如神情淡漠、抑郁、困倦、嗜睡等。其症状一般在休息和睡眠后消失。

取穴 内关

定位 在前臂掌面的下段,当曲泽与大陵的连线上,大陵(腕横纹)上2寸,掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间,约与外关相对。舒腕仰掌取穴(图8)。

操作方法 取双侧穴位。直刺1寸左右。得气后施以捻转提插手法,强刺激。留针20~30分钟。

注意事项

(1) 针刺内关穴可即刻改善症状。

(2) 先针单侧穴位,效果不显再加用双侧。

文献参考 《循经考穴编》:“内关:治翻胃膈气、中满痞胀、脾胃不和、脏腑胸胁一切疾痛。”

34. 头 痛

头痛是一种自觉症状,可见于多种急慢性疾病中。

(1) 感冒头痛

取穴 风池

定位 在项部,枕骨之下,胸锁乳突肌与斜方肌上端之间的凹陷处,风府穴的外侧。重按时鼻腔有酸胀感(图6)。

操作方法 取双侧穴位。向对侧眼球方向刺入1~1.5寸,得气后施以捻转手法,强刺激,使针感传至侧头部。每5~10分

钟行针1次,留针20~30分钟。

注意事项 针刺时针尖不可偏向内侧,以免针入椎管而损伤延髓。

文献参考 《针灸大成》:“风池:主……偏正头痛。”

(2) 高血压头痛

取穴 太阳

定位 在颞部,当眉梢与目外眦之间,向后约1横指的凹陷处(图3)。

操作方法 取双侧穴位。用细三棱针快速点刺穴位,使出血数滴。

注意事项 点刺前可先在穴位局部揉按片刻,使之易于出血。

文献参考 邓氏应用点刺太阳穴放血治疗高血压头痛共50例。其中痊愈13例,占26%;显效17例,占34%;有效16例,占32%;无效4例,占8%。(邓世发:点刺太阳穴放血治疗高血压头痛疗效观察,中国针灸,(3):9,1983)

(3) 外伤性头痛

取穴 阿是穴

定位 患处局部。

操作方法 在头痛局部寻找压痛点,双针齐刺,沿皮向相对方向各刺入1寸左右。得气后施以快速捻转手法,强刺激,以患者感觉局部胀痛或胀重为度。留针20~30分钟。隔日1次,

7次为1个疗程。

注意事项 起针后必须用消毒干棉球按压针孔片刻，以防出血。

35. 偏 头 痛

偏头痛是由于血管收缩功能障碍引起的半侧头痛。大多局限于单侧，以反复发作性剧烈头痛为特征。女性多见，常于青春期起病，呈周期性发作。发病前常有视幻觉、偏盲、唇指麻木等先兆症状，随即出现一侧头痛，为搏动性钻痛、钝痛或刺痛，持续数小时或数日，可伴有面色苍白或发红、眼结膜出血、流泪、疲倦无力、恶心、呕吐、腹胀、腹泻等植物神经功能紊乱及消化道症状。体检无异常发现。

取穴 丝竹空

定位 在面部，当眉梢凹陷处(图3)。

操作方法 直刺进针，得气后，针尖向率谷穴(耳尖直上，入发际1.5寸)方向沿皮透刺，约3~4寸，使针尖达率谷穴皮下。施以快速捻转手法，强刺激，使针感扩散至半边头部。留针20~30分钟。隔日1次，7次为1个疗程。

注意事项

(1) 向率谷穴透刺时，须掌握针刺方向，缓慢进针，不可将针尖刺出皮肤。

(2) 本法刺激量较强。

文献参考

(1) 《玉龙歌》：“偏正头风痛难医，丝竹金针亦可施；沿皮

向后透率谷，一针两穴世间稀。”

(2) 包氏应用针刺丝竹空透率谷穴治疗偏头痛共 31 例。其中治愈 16 例，显效 7 例，好转 6 例，无效 2 例。针刺次数最少者 4 次，最多者 30 次，一般针刺 7~15 次即可控制症状。(包兆贵：针刺丝竹空透率谷穴治疗偏头痛 31 例，陕西中医 (9)：418，1989)。

36. 面神经麻痹

面神经麻痹，是指因急性非化脓性面神经炎所致的周围性面神经麻痹。病因不明，可能与病毒感染有关。多见于单侧，起病突然，常于晨起洗漱时发现面部僵硬或口眼歪斜。患侧表情肌瘫痪，额纹消失，眼裂不能闭合，鼻唇沟变浅，口、面牵向健侧，露齿时表现更为明显，不能做皱额、闭目、鼓颊等动作，口水常从患侧口角外流。患侧耳内、耳后乳突区及面部可有疼痛。本病属于中医“口喎”、“口僻”、“口眼喎斜”的范畴。俗称“面瘫”。

取穴 下关

定位 在面部，耳前方，当颧弓下缘切迹所围成之凹陷处(图3)。

操作方法 取患侧穴位。闭口取穴。直刺约 1 寸深，得气后施以大幅度提插捻转手法，并作多向透刺，强刺激。留针 20~30 分钟。留针期间加用温针灸。每日 1 次，10 次为 1 个疗程。

注意事项 本法刺激量较强，须注意刺破血管引起血肿。

如有血肿产生，可嘱病人自作热敷处理，局部改为艾条温和灸，每日1次，待血肿消退后仍施原法治疗。

文献参考 《针灸甲乙经》：“口喎僻，……下关主之。”

37. 坐骨神经痛

坐骨神经痛是指在坐骨神经通路及其分布区域内的疼痛。主要症状为臀部、大腿后侧、腘窝、小腿外侧及足外侧发生放射性、烧灼样或针刺样疼痛，可因弯腰、咳嗽而加剧。沿坐骨神经通路上有明显的压痛点，直腿抬高试验及直腿抬高踝背屈试验阳性。按其病因，坐骨神经痛可分为原发性和继发性两类。前者的发病与受寒、潮湿、损伤以及感染有关，后者多继发于腰椎间盘突出、腰椎关节、髋髂关节及盆腔内各种疾病。本病属于中医“痹症”的范畴。

方 一

取穴 秩边

定位 在臀部，平第4骶后孔，骶正中嵴旁开3寸，即腰俞穴的外侧3寸处(图6)。

操作方法 取患侧穴位。直刺3~4寸。得气后施以提插捻转手法，强刺激，使针感向下肢放射。留针20~30分钟。每日或隔日1次，10次为1个疗程。

注意事项 针刺时应使针感向下肢放射。获取针感后，不宜再多作提插，以免损伤神经。

文献参考

(1) 《针灸甲乙经》：“腰痛骶寒，俯仰急难，……秩边主之。”

(2) 《铜人输穴针灸图经》：“秩边：治腰痛不能俯仰，小便赤涩，腰尻重不能举。”

(3) 崔氏应用针刺秩边穴为主治疗坐骨神经痛共300例。其中痊愈113例，占37.6%；显效121例，占40.4%；好转46例，占15.2%；无效20例，占6.8%；总有效率为93.2%。（崔述贵：针刺秩边穴治疗坐骨神经痛 300 例疗效观察，山西中医，(4):36,1990)

方 二

取穴 腰部夹脊

定位 第3腰椎至第5腰椎，各椎棘突下旁开0.5寸。

操作方法 每次取1~2穴，直刺约2~3寸，得气后施以提插捻转手法，强刺激，以针感向下肢放射为度。留针20~30分钟。每日或隔日1次，10次为1个疗程。

注意事项 针刺时应使针感向下肢放射。获取针感后，不宜再多作提插，以免损伤神经。

38. 股外侧皮神经炎

股外侧皮神经炎又称感觉异常性股痛症。是一种股外侧皮肤感觉异常的疾病，病因不明。一般多见于单侧，患者自觉大腿前外侧皮肤麻木、疼痛，或有蚁行、针刺、烧灼、怕冷、沉重等异常感觉，体力活动或久立、久坐后症状加重。检查局部无

红肿，可发现大小不等的感觉迟钝区或感觉过敏区。肌肉运动和关节活动均无异常。X线检查可排除骨折和其他疾病。

取穴 阿是穴

定位 患处局部。

操作方法 用皮肤针在局部进行叩刺，强刺激，以皮肤微有出血为度，然后加拔火罐。每日1次，7次为1个疗程。

文献参考 郑氏等应用局部梅花针叩刺加用走罐法治疗股外侧皮神经炎共31例。结果痊愈27例，显效2例，有效1例，无效1例，总有效率为96.7%。（郑少祥等：梅花针加走罐法治疗股外侧皮神经炎，浙江中医杂志(12)：548,1988）

39. 阑 尾 炎

阑尾炎是外科常见的急腹症之一。阑尾腔的堵塞，如粪石、炎症、异物或肿瘤等均可引起阑尾炎。阑尾炎可分为急性和慢性两种。急性者初起时上腹部或脐周围疼痛，数小时后转移至右下腹部，呈持续性并可有阵发性加剧。右下腹阑尾点压痛明显，或有反跳痛和肌紧张。常伴有恶心、呕吐、食欲减退、腹胀、腹泻、便秘、发热等全身症状。外周血白细胞总数和中性白细胞百分数明显增高。慢性阑尾炎则以右下腹隐痛和局限性压痛为主，可反复发作。本病属于中医的“肠痈”范畴。

取穴 阑尾

定位 小腿前外侧上部，当犊鼻下5寸，胫骨前缘旁开1横

指(图10)。

操作方法 取双侧穴位。在外膝眼下5寸左右处寻找压痛点,指压酸痛最明显处是穴。直刺约2寸深,得气后施以提插捻转手法,强刺激,以疼痛缓解为度。留针30分钟。

注意事项

(1) 本法适用于阑尾炎早期,如形成脓肿或已有穿孔,则疗效较差。

(2) 慢性阑尾炎亦可采用本法治疗,可缓解症状,但易复发。

文献参考

(1) 上海市中山医院应用针刺治疗阑尾炎共164例,以阑尾穴为主穴,总治愈率为86.4%。针刺失败的有17例,占10.4%。其中12例行手术治疗,发现其主要原因为阑尾已有严重病变、阑尾粪石梗塞、阑尾壁增厚、阑尾组织纤维化等。(上海第一医学院中山医院:上医学报,(5):355,1959)

(2) 韩氏应用蒸馏水穴位注射阑尾穴治疗单纯性阑尾共97例。均经治疗2~4次而获痊愈。一般治疗1次后自觉症状消失,2次后压痛,反跳痛消失,继续注射1~2次以巩固疗效,血象恢复正常。随访1~5年无1例复发。(韩铁山:蒸馏水封闭阑尾穴治疗单纯性阑尾97例临床观察,光明中医,(1):15,1989)

40. 乳 痛

乳痛,即急性乳腺炎,是乳腺的化脓性炎症。多发于初产妇哺乳期,常在产后3~4周发生。初起时乳房肿胀疼痛,局部

变硬且有压痛,数天后炎块软化形成脓肿,可有波动感,并向外或乳管内溃破流脓。常伴有畏寒、发热、头痛、恶心、食欲减退等全身症状。患侧腋窝淋巴结肿大,并有压痛。血白细胞总数和中性白细胞分类计数增高。

取穴 肩井

定位 在肩部,当大椎与肩峰端连线的中点处(图6)。

操作方法 取双侧穴位。直刺约1寸,得气后施以提插捻转手法,强刺激。留针20~30分钟。每日1次,7次为1个疗程。

注意事项 不宜垂直深刺,以免刺入胸腔而造成气胸。

文献参考

(1)《百证赋》:“肩井乳痛而极效。”

(2)高氏等应用针刺肩井穴治疗急性乳腺炎共393例。其中痊愈390例,占99.2%;无效3例,占0.8%。(高殿奎等:针刺肩井一穴治疗急性乳腺炎393例疗效观察,中国针灸,(1):13,1985)

41. 痔 疮

痔疮为直肠下端粘膜或肛管皮肤静脉丛扩大、曲张的静脉团。其主要症状为脱出、疼痛、出血和有异物感。根据痔的部位可将其分为三种,凡表面是粘膜的称内痔,表面是皮肤的称外痔,内外痔同时存在的称混合痔。直肠检查可确诊。

取穴 承山

定位 在小腿后面正中,委中穴下8寸处,或外踝尖上8寸处,当伸直小腿或足跟上提时腓肠肌肌腹下出现尖角凹陷处(图11)。

操作方法 取双侧承山穴,向上斜刺约2寸深。得气后施以提插捻转手法,强刺激,使针感向上传导。留针30分钟。每日或隔日1次,10次为1个疗程。

文献参考

(1)《铜人输穴针灸图经》:“承山:治……大便难,久痔肿痛。”

(2) 赵氏观察了针刺承山穴对 100 例痔疮疼痛患者的止痛效果。针刺后患者即感到疼痛明显减轻,肛门部疼痛基本消失,可下床活动者为显效;针刺后患者即感到疼痛明显减轻,起针后稍留痛感者为有效;针刺后与针刺前一样疼痛者为无效。共治疗内痔15例,外痔25例,分别显效10例、18例;好转3例、5例;有效2例、1例;外痔无效1例。混合痔60例,显效42例,好转12例,有效4例,无效2例。有效率分别为100%、96%、96.7%。(赵宝文:针刺承山穴对痔疮疼痛100例止痛效果的观察,中国针灸,(2):23,1986)

42. 直 肠 脱 垂

直肠脱垂是指肛管、直肠,甚至乙状结肠下端脱垂于肛门外的一种疾病,俗称“脱肛”。脱出部分仅为直肠粘膜者,称部分脱垂;若肠壁全层脱出,则称为完全脱垂。本病多见于儿童、老年人及多次分娩的妇女。病初起时尚可自行回纳,日久须用手托方可缩回。患者自觉肛门有坠胀感。脱出肠管常

有充血、水肿、糜烂及出血。直肠检查可发现肛门括约肌松弛。

方 一

取穴 四神聪

定位 在头顶部,百会穴之前、后、左、右各1寸处,共4穴(图2)。

操作方法 四穴针入后,分别向百会穴透刺。得气后施以快速捻转手法,强刺激,以患者感觉头顶部胀重为度。留针20~30分钟。留针期间加以艾条温和灸。隔日1次,10次为1个疗程。

注意事项 起针后必须用消毒干棉球按压针孔片刻,以防出血。

方 二

取穴 长强

定位 在尾骨端下,当尾骨端与肛门连线的中点处(图6)。

操作方法 患者侧卧抱膝,沿尾骨内侧面与尾骨平行向上刺入约1.5~2寸,得气后施以捻转手法,强刺激。留针20~30分钟。隔日1次,10次为1个疗程。

注意事项

(1) 针刺时必须注意针刺方向,不可直刺,以免伤及直肠。

(2) 须严格消毒,防止感染。

43. 荨 麻 疹

荨麻疹是一种常见的变态反应性皮肤病。常由于食物、药物、感染、昆虫叮咬而引起。临床表现为大小不等、形状不一的红色或白色风团,突然发生,数小时后又迅速消退,瘙痒剧烈,愈后不留痕迹。严重者,呼吸道、消化道等均受累,可出现发热、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、胸闷、气急、呼吸困难、甚则窒息等症状。本病属于中医“瘾疹”、“风疹”的范畴。

取穴 血海

定位 屈膝,在大腿内侧,髌骨内侧端上2寸,当股四头肌内侧头的隆起处(图10)。

操作方法 取双侧穴位。略向上斜刺,进针约1~1.5寸左右。得气后施以捻转手法,强刺激。留针30分钟。每日或隔日1次,3次为1个疗程。

注意事项

(1) 如针感不够强烈,可采用下法:拇指向前,食指向后,单方向捻针,至针身不能转动为止,再将针轻轻往上提动。

(2) 本法可即刻缓解瘙痒等症状。

文献参考 戴氏应用针刺血海穴为主治疗瘙痒性皮肤病共30例。治疗次数最多者32次,最少者4次。痊愈(治疗后皮损全部消退,痒感消失)19例,占63.3%;好转(治疗后皮损消退1/3,痒感明显减轻)9例,占30%;无效(治疗一周,皮损及痒

感无改善)2例,占6.7%;总有效率达93.3%。(戴蜀平:针刺血海穴为主治疗瘙痒性皮肤病30例,辽宁中医杂志,(11):27,1989)

44. 湿 疹

湿疹是一种常见的过敏性皮肤病,可由多种因素引起。局部瘙痒剧烈,常反复发作。皮肤损害呈多形性,如红斑、丘疹、水疱、渗出、糜烂、结痂、色素沉着、苔藓样变等,多对称分布,可见于全身各处。中医的“浸淫疮”、“旋耳疮”、“绣球风”、“四弯风”等疾病均属于本病的范畴。

取穴 阿是穴

定位 患处局部。

操作方法 用皮肤针在病变局部进行叩刺,中强刺激,以皮肤潮红并略有出血为度。针后局部加拔火罐。隔日1次,7次为1个疗程。

注意事项 在病变局部针刺和拔火罐时,须注意无菌操作,防止感染。

45. 带 状 疱 疹

带状疱疹是由带状疱疹病毒所致的急性疱疹性皮肤病。多见于胸背、面部和腰部。初起时局部发红,有带索状刺痛,常伴有轻度发热、乏力、食欲不振等全身症状。随后出现密集成簇的米粒至绿豆大小的水疱,排列呈带状,沿周围神经单侧

分布,疼痛剧烈,局部有烧灼感。病程一般2~3周,渐见干燥结痂而愈。愈后不留疤痕。

取穴 阿是穴

定位 患处局部。

操作方法 用皮肤针在疱疹周围皮肤进行叩刺,中强刺激,以皮肤潮红为度。再沿皮损部位局部加拔火罐。每日1次,7次为1个疗程。

注意事项

(1) 须注意无菌操作,防止感染。如水疱破溃,局部可涂以龙胆紫药水。

(2) 本法可缩短病程,减缓疼痛。

文献参考

(1) 王氏应用梅花针局部叩刺治疗带状疱疹共192例,全部治愈。其中3次治愈者166例,4次治愈者20例,5次治愈者3例,7次治愈者2例,10次治愈者1例。3次治愈率达86.5%。(王善生:梅花针治疗带状疱疹192例,山东中医杂志,(2):24,1989)

(2) 张氏等应用局部火罐疗法治带状疱疹共111例,全部痊愈。其中疗程最短者2天(次),最长者10天(次)。平均治愈时间为4.2天(次),无1例后遗症。(张天文等:火罐疗法治带状疱疹111例,中国针灸,(2):46,1986)

46. 丹 毒

丹毒是由链球菌引起的皮肤及皮下组织的急性炎症,好

发于面部及下肢。以发病急速、皮肤鲜红成片、色如赤丹为其特征。患者常有恶寒、发热、全身不适等前驱症状，继而局部出现大片状水肿性鲜红斑片，边缘清楚，表面发亮，并很快向四周蔓延，其中心颜色由鲜红转为暗红，可见有表皮脱屑或黄色水疱。患者自觉局部灼热疼痛，触之尤甚。可伴有高热、烦躁、口渴、便秘等症状。实验室检查常见血白细胞总数和中性白细胞分类计数增高。

取穴 阿是穴

定位 患处局部。

操作方法 在患处局部用细三棱针散刺出血，或用皮肤针重度叩刺，针后局部加拔火罐。每日或隔日1次，7次为1个疗程。

注意事项

(1) 须注意消毒，防止交叉感染。

(2) 本法刺激量较强，施治时须得到病人配合。

文献参考 程氏应用络刺法为主治疗丹毒共21例。用圆利针络刺皮损周围浅静脉，同时点刺血海穴和隐白穴。每日或隔日1次。结果除2例自动停针外，其余全部痊愈。（程隆光：络刺法治丹毒21例，中国针灸，6(4)：33，1986）

47. 神经性皮炎

神经性皮炎是以阵发性皮肤瘙痒和皮肤苔藓样变为主症的慢性炎症性皮肤病。情绪变化、局部摩擦常为诱因。好发于四肢的外露部位，以颈后部和颈侧面、四肢伸侧、尾骶部等

处最为常见。先有局部瘙痒，搔抓后出现圆形或多角形扁平丘疹，密集成群，日久丘疹融合成片，皮肤增厚干燥，皮纹加深而呈苔藓样变，皮损处有阵发性剧烈瘙痒。本病属于中医“牛皮癣”、“顽癣”的范畴。

取穴 阿是穴

定位 患处局部。

操作方法 常规消毒后，用皮肤针叩刺局部，手法由轻到重，使皮肤微微出血。再用艾条施以温和灸，以局部略觉热痛为度。隔日1次，10次为1个疗程。

注意事项 皮肤针叩刺后可用大蒜在局部略作涂擦，然后再施艾灸。

文献参考 刘氏应用小艾炷灸治神经性皮炎共120例。先在皮损局部涂以大蒜汁，然后施灸。每10天1次，至皮损正常后停灸。结果近期痊愈107例，占89%。（刘华：小艾炷灸治神经性皮炎，中医杂志，2(2)：7，1980）

48. 银 屑 病

银屑病是一种常见的慢性炎症性皮肤病，病因未明。皮损可散布全身，但多发于四肢伸侧和头顶部。初起为散在性米粒或绿豆大小之暗红色丘疹，顶覆鳞屑，逐渐皮损变大形成斑片，鳞屑明显增多，呈多层云母状，若层层剥去，基底部可见浅红而光滑的薄膜，再剥即可见点状出血，患者自觉瘙痒。本病属于中医“松皮癣”、“干癣”、“白癣”的范畴。

取穴 阿是穴

定位 患处局部。

操作方法 剥去鳞屑,常规消毒后,用皮肤针叩刺局部,轻刺激,使皮肤微微出血。再用艾条施以温和灸,以局部略觉热痛为度。隔日1次,10次为1个疗程。

注意事项

用皮肤针局部叩刺时手法不宜太重。

文献参考 宋氏应用梅花针局部叩刺加用药艾熏灸治疗银屑病共8例,均获痊愈。(宋福荣:梅花针加药艾熏灸治疗银屑病,新中医,(1):39,1988)

49. 白 癜 风

白癜风是一种局限性色素代谢障碍性皮肤病,病因不明,可发于皮肤的任何部位。皮损为圆形或不规则形的白色斑块,大小不等,边界清楚,白斑内毛发亦可变白,边缘处常色素加深。病程较长,一般无自觉症状,日晒后皮损处可变红或有灼痛。

取穴 阿是穴

定位 患处局部。

操作方法 常规消毒后,用皮肤针叩刺局部,手法由轻到重,使皮肤微微出血。再用艾条施以温和灸,以局部潮红,略觉热痛为度。隔日1次,10次为1个疗程。

注意事项 针灸治疗本病疗程较长。

文献参考 李氏应用局部艾条灸治疗白癜风共6例。灸

治时艾条距皮肤以患者能够忍受为度，并由外向内逐渐移动缩小灸治范围，将白斑灸至高度充血。每日1~2次，一般灸至30次左右白斑即转为正常肤色或接近正常肤色。（李洪福：艾条灸治愈白癜风6例，中国针灸，(3):29,1983）

50. 疣

疣是由疣病毒所致的一种皮肤良性赘生物，包括扁平疣和寻常疣。扁平疣多发于面部及手背等处，为散在的淡褐色扁平丘疹，如针头至黄豆大小，呈圆形或长圆形，边缘清楚，表面光滑，一般无自觉症状或偶有瘙痒感。寻常疣则为半圆形或多角形隆起的赘状物，质地略硬，小如粟米，大如黄豆，表面粗糙，呈灰褐色或暗黄色，多发于手背、指背，亦可见于颜面部，一般无自觉症状或偶有压痛。根据寻常疣的发生部位和形状，还可有指状疣、丝状疣、趾疣等名称。

取穴 阿是穴

定位 患处局部。

操作方法 患处局部常规消毒后，用细三棱针在酒精灯上烧红，迅速由疣的中央刺入，深达疣根即止。隔日1次，3次为1个疗程。

注意事项

(1) 针后局部一般不需其他处理，可任疣自然脱落。

(2) 如疣较多，不可一次针刺过多，可分批针刺。

文献参考 马氏应用火针烧灼局部治疗寻常疣，以完全烧损为度，共治疗55例，治愈率为95%。（马志超：鞍钢火针治

疣与痣,中国针灸,7(5):55,1987)

51. 斑 秃

斑秃是一种常见的局限性脱发病症。多发于青壮年,原因不明,可能与精神因素有关。临床表现为突然发病,发生大小不等圆形或椭圆形的斑状秃发,局部皮肤正常,无自觉症状。严重者头发可全部脱光,称全秃。

取穴 阿是穴

定位 患处局部。

操作方法 患处局部常规消毒后,用皮肤针叩刺,强刺激,以皮肤隐隐出血为度。隔日1次,10次为1个疗程。

注意事项 皮肤针叩刺后可在局部用生姜或大蒜涂擦,亦可涂以市场所售的生发药水。

文献参考 化氏应用局部梅花针叩刺配合复方斑蝥酊涂擦治疗斑秃共105例。其中痊愈46例,占43.8%;显效21例,占20%;好转13例,占12.4%;进步10例,占9.5%;无效15例,占14.3%。多数患者在治疗1个月左右斑秃局部开始生长绒毛,逐渐变成新发。(化芝玉:梅花针配合复方斑蝥酊治疗斑秃105例,中国针灸,(4):43,1982)

52. 鸡 眼

鸡眼是足部皮肤的局限性圆锥状角质增生性损害。多因负重不当、足畸形和穿鞋不合适,使足部受到长时间挤压或摩

擦而引起。局部损害为黄豆至豌豆大小，状如鸡眼，质坚硬，略高于周围皮肤，境界清楚。好发于足部的易受压或摩擦部位。压痛和行走疼痛是其主要临床症状。

取穴 阿是穴

定位 患处局部。

操作方法 患处局部常规消毒后，用较粗之1寸毫针刺入鸡眼中心基底部，得气后施以大幅度提插捻转，随即出针。再用艾条在局部施以温和灸，以略感热痛为度。每周1次，3次为1个疗程。

注意事项

(1) 针刺时针尖须达鸡眼基底部，否则易复发。

(2) 本法刺激量较强，施用前应向病人解释清楚。

(3) 亦可应用火针疗法。常规消毒后，将毫针或细三棱针在酒精灯上烧红，对准鸡眼中心刺入，至有痛感即止。一般只刺1次，不必再加艾条灸。

(4) 针灸后局部须略加包扎，以防感染。

文献参考

(1) 臧氏应用针刺鸡眼局部治疗鸡眼共18例。用毫针刺入鸡眼中心，针尖达基底部，留针20~30分钟，出针后挤压鸡眼使之微出血，用胶布贴敷。3日一次。结果全部痊愈。随访3~6年未见复发。(臧胜义：针刺治鸡眼，四川中医，(2):16, 1985)

(2) 李氏应用局部温和灸治疗鸡眼共36例。先用温水浸泡患处，然后施用艾条灸，以略感疼痛、皮肤红润为度，每日1次，7次为1疗程。结果2~3个疗程后，痊愈29例，占80.6%。

好转7例,占19.4%。6个月后复发者5例,占13.9%。(李德明:温和灸治疗鸡眼36例,江西中医药,(6):37,1988)

3. 李氏应用火针治疗鸡眼共60例。在鸡眼局部刺入,达基底部,一般只刺1次。治愈59例。观察1年以上未复发。(李炜:火针治愈鸡眼60例,天津中医,(2):39,1990)

53. 冻 疮

冻疮是由寒冷引起的皮肤损害。多发生在手、足、耳等暴露部位,为暗红色水肿性红斑,部位局限,大小不等,压之退色,自觉有瘙痒、麻木或灼痛感,温暖尤甚。严重者可产生水泡,破溃后形成溃疡,溃烂后疼痛加重。

取穴 阿是穴

定位 患处局部。

操作方法 常规消毒后,用皮肤针叩刺局部,手法由轻到重,使皮肤微微出血。再用艾条施以温和灸,以局部略觉热痛为度。每日1次,7次为1个疗程。

注意事项 如冻疮已溃,可用皮肤针叩刺冻疮周围,或只采用艾条温和灸。

54. 颞下颌关节功能紊乱症

颞下颌关节功能紊乱症是一种常见的颞颌关节疾病,以青年女性多见。患者下颌关节运动受限,张、闭口时关节发生弹响或杂音,局部疼痛,咀嚼、讲话,晨起后张口疼痛尤甚。在

患处常有压痛点。偶可伴有头痛、头昏、耳鸣、听觉障碍等其他症状。

取穴 下关

定位 在面部，耳前方，当颧弓与下颌切迹所围成之凹陷处(图3)。

操作方法 取患侧穴位。闭口取穴，直刺约1寸深，得气后施以提插捻转手法，并作多向透刺，强刺激，时间1~2分钟。然后将针提至皮下，嘱患者作张、闭口动作，一般即觉症状有所减轻，再将针重新刺入。留针20~30分钟。隔日1次，3次为1个疗程。

注意事项

(1) 针在穴位深处时，不可让患者作张、闭口动作，以防弯针。

(2) 本法刺激量较强，须注意刺破血管可引起血肿。如有血肿产生，可先作冷敷止血后，再作热敷，以促使局部瘀血消散吸收。

文献参考 陈氏应用针刺下关穴治疗颞下颌关节功能紊乱症共43例。其中痊愈25例，好转13例，无效5例。(陈英炎：针刺下关穴治疗颞下颌关节功能紊乱症43例，浙江中医杂志(7):40,1966)

55. 落 枕

落枕，又称颈部伤筋。多因睡眠时体位不正、枕头过高，或劳损、扭伤、感受风寒等所引起。临床表现以颈项强直、疼

痛为主。患者自觉颈项强硬不舒,局部肌肉痉挛,触之有明显压痛。颈部活动受限,头斜向患侧,下颌歪向健侧,转颈时疼痛加剧并向肩部及上臂放射。

取穴 后溪

定位 在手尺侧,第5掌骨小头的后下方。握拳时,当远侧掌横纹头上方的凹陷处,赤白肉际(图9)。

操作方法 取双侧穴位。双手握拳,直刺1~1.5寸。得气后施以提插捻转手法,强刺激,同时嘱患者前后左右活动颈项部,每3~5分钟行针1次。留针30分钟。

注意事项 针刺时,使针感向上传导则疗效较佳。

文献参考

(1)《铜人输穴针灸图经》:“后溪治……颈项强,不得回顾。”

(2) 杨氏应用针刺后溪穴治疗落枕共54例。取单侧穴位,针刺同时令患者作左右摇头动作,待疼痛减轻或消失时出针。结果痊愈33例,好转19例,无效2例,总有效率为96%。一般针刺1~2次即可见效。(杨富华:针刺后溪穴治疗落枕54例,中国针灸,(3):19,1985)

56. 颈 椎 病

颈椎病又称颈椎综合征,是由于颈椎间盘退行性变及颈椎骨质增生,刺激或压迫颈神经根、颈部脊髓、椎动脉或交感神经等而引起的综合症候群。以反复发作的颈肩部疼痛为主要临床表现,疼痛常向一侧或双侧上肢放射。轻者可出现手

指麻木、持物不稳、肌肉萎缩等神经受压症状，重者甚至引起瘫痪和大、小便失禁。病变累及椎动脉或交感神经时则可出现头晕、耳鸣、胸闷、心悸等相应的临床症状。检查时可在颈肩部发现明显的压痛点。臂丛神经牵拉试验和压顶、叩顶试验阳性。X线检查可帮助确诊。本病临床上常分为神经根型、脊髓型、椎动脉型、交感神经型和混合型五种类型，而以混合型最为多见。

取穴 颈部夹脊

定位 第3颈椎至第7颈椎，各椎棘突下旁开0.5寸。

操作方法 直刺约1寸左右，得气后施以提插捻转手法，中刺激。留针20~30分钟。留针期间加用温针灸，灸3壮。隔日1次，10次为1个疗程。

注意事项

- (1) 针刺时针尖须直刺至骨。
- (2) 不可向内侧斜刺，以免伤及脊髓。

文献参考 浦氏等应用温针夹脊穴治疗颈椎病共22例，其中显效7例，有效12例，无效3例。（浦蕴星等：温针夹脊穴治疗颈椎病，上海针灸杂志，(2):18,1984）

57. 颈 肩 痛

颈肩部疼痛是临床上常见的症状。颈肩部骨折、脱位、炎症、肿瘤、神经和血管等疾患均可引起颈肩部疼痛。临床上以急性软组织损伤、慢性软组织劳损、颈椎病等颈部疾病引起的颈肩痛最为常见。患者可有外伤或受风着凉史。颈项部疼

痛,并向肩背部放散,颈肌僵硬或痉挛,颈部活动时患处有牵扯感或不适。局部往往有明显的压痛点。

方 一

取穴 风池

定位 在项部,枕骨之下,胸锁乳突肌与斜方肌上端之间的凹陷处,风府穴的外侧。重按时鼻腔有酸胀感(图6)。

操作方法 在风池穴处寻找压痛点,在压痛点上针刺。直刺约1寸,得气后施以提插捻转手法,强刺激,并将针尖向四周透刺。留针 20~30 分钟。

注意事项 不宜针刺过深,以防刺入枕骨大孔而损伤延髓。

文献参考

- (1) 《针灸甲乙经》:“颈痛,项不得顾,……风池主之。”
- (2) 《针灸大成》:“风池:主……颈项如拔,痛不得回顾。”

方 二

取穴 肩井

定位 在肩部,当大椎与肩峰端连线的中点处(图6)。

操作方法 直刺约1寸,得气后施以提插捻转手法,并将针尖提至皮下向颈部、肩胛部、肩峰部作多向透刺,强刺激。留针 20~30 分钟。

注意事项 不宜垂直深刺,以免刺入胸腔而造成气胸。

文献参考

(1) 《针灸甲乙经》：“肩背髀痛，臂不举，寒热凄索，肩井主之。”

(2) 《针灸大成》：“肩井：主……头项痛，五劳七伤，臂痛，两手不得向头。”

58. 肩 背 痛

肩背痛是指肩关节及其周围筋肉组织疼痛，并连及肩胛的症状。患者自觉肩背部酸痛不舒，肩部用力及上肢活动时疼痛加剧。肩胛骨内上角、肩胛内缘、肩胛区处常有明显的压痛点。有时并可触及硬结或条索状物。

取穴 曲垣

定位 在肩胛部，岗上窝内侧端，当臑俞与第2胸椎棘突连线的中点处(图6)。

操作方法 在患侧曲垣穴处寻找压痛点，直刺约0.5寸。得气后施以提插捻转手法，强刺激，并将针尖向四周作多向透刺，同时被动活动患侧肩关节。留针20~30分钟。留针期间加用温针灸，针后局部加拔火罐。每日1次，3次为1个疗程。

注意事项 曲垣穴正当肩胛骨的岗上窝内侧端，刺入穴位时针下应有刺至骨上的感觉。作局部多向透刺手法时，应注意针尖不可向内侧针刺过深，以免刺入胸腔，造成气胸。

文献参考

(1) 《针灸甲乙经》：“肩胛周痹，曲垣主之”。

(2) 《针灸大成》：“曲垣：主肩痹热痛，气注肩胛，拘急

痛闷。”

59. 胸 痛

胸痛是临床上常见的症状。胸壁病变、胸腔脏器病变、纵隔病变等均可引起胸痛。胸痛的严重程度与原发病性质的严重性并不一定平行。在临床上应注意胸痛的特点，如胸痛开始的方式、部位、性质、强度、有无放射、疼痛时限、加重和缓解因素等等。必要时应进行X线、心电图以及血清酶学等检查。

取穴 鱼际

定位 在手掌侧面鱼际部的桡侧缘(赤白肉际)，当拇指掌指关节与腕掌关节的中点的凹陷处，约当第1掌骨中点桡侧(图8)。

操作方法 取双侧穴位。在鱼际穴附近寻找压痛点，直刺约0.5~1寸。得气后施以提插捻转手法，强刺激。留针30分钟。

注意事项

(1) 本法主要适用于肺及胸膜的病变。应用本法治疗，一般可即刻缓解症状。

(2) 本法刺激量较强。

文献参考

(1) 《灵枢·厥病》：“厥心痛，卧如徙居心痛间，动则痛益甚，色不变，肺心痛也，取之鱼际、太渊。”

(2) 《铜人输穴针灸图经》：“鱼际：治……痹走胸背，痛不得息。”

60. 胁 肋 痛

胁肋痛是指一侧或两侧胁肋发生疼痛而言,常见于肝脏、胆囊、胸膜等急、慢性疾患,而肋间神经痛、带状疱疹、胸肋外伤、胸背肌群发生痉挛等亦可引起胁肋痛。疼痛性质可为隐痛、胀痛、钝痛、刺痛或绞痛,多因呼吸、咳嗽、喷嚏、上肢活动等而诱发或呈阵发性加剧。

方 一

取穴 支沟

定位 在前臂背侧,当阳池与肘尖的连线上,阳池穴上3寸处,尺骨与桡骨之间(图7)。

操作方法 取患侧或双侧穴位。向上斜刺,进针约1~1.5寸,得气后施以提插捻转手法,强刺激。留针20~30分钟。

注意事项 行针时应嘱患者作深呼吸、咳嗽、转动上肢等动作,一般可即刻感觉症状有所减轻。

文献参考

(1)《针灸甲乙经》:“……胁腋急痛,……支沟主之。”

(2) 张氏应用针刺支沟穴治疗胁痛共18例。痊愈16例,有效2例。其中7例针刺1次,9例针刺3次,2例针刺6次。(张瑜:针刺支沟治疗胁痛18例,陕西中医,(4):186,1988)

方 二

取穴 胸部夹脊

定位 按相应神经节段取穴。在胸椎棘突下旁开0.5寸。

操作方法 按疼痛部位沿肋骨寻找相应的夹脊穴，一般局部多有压痛点或阳性反应物。直刺约1寸，得气后施以提插捻转手法，中刺激，以针感略有放射为度。留针20~30分钟。

注意事项 针尖不可向外侧斜刺，以免刺入胸腔造成气胸。

文献参考 《素问·缪刺论》：“邪客于足太阳之络，令人拘挛背急，引胁而痛。刺之从项始，数脊椎，侠脊，疾按之，应手如痛，刺之傍三指，立已。”

61. 肋 软 骨 炎

肋软骨炎为肋软骨的慢性非特异性炎症，多见于胸骨旁第2~4肋软骨。患处肋软骨肿胀隆起，有钝痛或锐痛，压痛明显，在深呼吸、咳嗽或活动上肢时疼痛加剧。局部皮肤并无炎症反应，X线检查一般无异常改变。

取穴 阿是穴

定位 患处局部。

操作方法 在压痛点上针刺，直刺约0.5寸，得气后施以提插捻转手法，强刺激，并将针尖向四周作多向透刺。留针20

~30分钟。

注意事项 针刺时应注意控制针尖的方向、角度和深度，以防刺入胸腔，造成气胸。

文献参考 孙氏应用局部阿是穴埋针法治疗肋软骨炎，将毫针沿肋骨方向在皮层与肌层之间水平刺入0.5~1寸，至症状减轻或消失后起针。疗效满意。（孙学全：埋针治疗非化脓性肋软骨炎，山东中医杂志，(5)：295，1982）

62. 肩关节周围炎

肩关节周围炎为肩关节周围软组织退行性、炎症性病变。俗称“漏肩风”、“冻结肩”、“肩凝”。因发病年龄多为50岁左右，故又有“五十肩”之称。多有肩部受寒、外伤、慢性劳损病史。以肩部疼痛、活动障碍为主要临床特征。肩痛开始时较轻，以后逐渐加重，其痛可向颈部和上臂放射。肩关节外展、上举、内旋、外旋功能均受限，严重者肩关节活动可完全消失。

取穴 条口

定位 在小腿前外侧，当犊鼻下8寸，距胫骨前缘1横指（图10）。

操作方法 取患侧或双侧穴位，直刺，向承山穴透刺约2~3寸深。得气后，施以提插捻转手法，强刺激，同时嘱患者活动肩关节。留针30分钟。每日或隔日1次，10次为1个疗程。

注意事项 本法以病程短者疗效较佳。

文献参考 胡氏应用针刺条口透承山治疗肩关节周围炎

共45例。基本痊愈(肩痛消失,肩臂活动自如,或肩部活动微感不灵活或微感疼痛)38例,好转(肩部疼痛消失或未全消失,肩臂抬举高于巅顶 20 厘米以上,或上举、内收、后伸、前屈,以及外展,其中 1 个或2个动作仍受限者)3例,疗效不巩固(针后取得治愈或好转,隔半日或1日活动与治疗前无变化)4例。(胡学曾:针刺条口透承山穴治疗45例肩凝症的初步体会,针灸杂志,(1):18,1966)

63. 岗上肌肌腱炎

岗上肌肌腱炎是常见的肩部疾病。主要表现为肩关节外侧疼痛,有时可向颈部或上肢放射,肩部活动时疼痛加重。检查可发现在肩峰与肱骨大结节之间有局限压痛,肩关节活动受限,尤以自动外展更加明显。在肩关节外展 $60^{\circ} \sim 120^{\circ}$ 范围内疼痛剧烈,不足或超越此范围则无疼痛。病久可导致肩部肌肉萎缩。

取穴 巨骨

定位 在肩上部,当锁骨肩峰端与肩胛岗之间凹陷处,一般适在第7颈椎棘突与肩髃穴间连线之外侧 $1/2$ 段的中点处(图6)。

操作方法 患者坐位,肩关节自然下垂。取患侧巨骨穴,针尖稍偏向外下方,直刺约1寸。得气后施以提插捻转手法,强刺激,然后将针提至皮下,被动外展患侧肩关节,再将针刺入,并施以大幅度提插捻转。如此反复多次,使肩关节外展幅度逐渐增大。留针20~30分钟。每日或隔日1次,7次为1个

疗程。

注意事项 针刺时针尖应偏向外下方,且不可过深,以防气胸。

文献参考

(1)《针灸甲乙经》:“肩背痛痹不举,血瘀肩中,不能动摇,巨骨主之。”

(2)《铜人输穴针灸图经》:“巨骨:治肩膊痛,胸中有瘀血,肩背不得屈伸而痛。”

64. 肱二头肌肌腱炎

肱二头肌肌腱炎包括肱二头肌长头肌腱炎和肱二头肌短头肌腱炎,是常见的肩部软组织损伤性疾病。前者在结节间沟处有持续性疼痛,凡能引起肱二头肌长头肌腱滑动的动作,均可使疼痛加剧,检查可见结节间沟处有明显压痛,有时可触及到粗硬的条索状物。后者主要表现为喙突处疼痛并有压痛,触之肌腱钝厚,伸肘抗阻力内收肩关节时疼痛加剧。本病是引起肩关节周围炎发病的主要原因之一。

取穴 阿是穴

定位 患处局部。

操作方法 取患侧穴位。在结节间沟和喙突处寻找压痛点,以压痛最明显处是穴。直刺约0.5~1寸,得气后施以提插捻转手法,强刺激,并将针尖向四周作多向透刺,同时被动活动患侧肩关节。留针20~30分钟。留针期间加用温针灸,针后局部加拔火罐。每日或隔日1次,7次为1个疗程。

注意事项 可采用局部多针齐刺，一般针刺后即可觉症状有所改善。

65. 肱骨外上髁炎

肱骨外上髁炎是肱骨外上髁周围软组织的无菌性炎症，俗称网球肘，多因前臂伸肌群的慢性劳损所致。主要症状为肱骨外上髁部位酸痛，握物无力，握拳、伸腕及作前臂旋转动作时酸痛加剧，并可向前臂外侧或肩背部放射。检查时局部无红肿，肱骨外上髁及肱桡关节处明显压痛。肘关节活动度正常，伸肌腱牵拉试验阳性。

取穴 阿是穴

定位 患处局部。

操作方法 在患者肘部找出压痛点，直刺至骨。得气后施以提插捻转手法，作多向透刺，强刺激，时间1~2分钟。留针时加用温针灸，以局部觉温热为度。起针后局部再加拔火罐。每日或隔日1次，10次为1个疗程。

注意事项

(1) 按压痛点取穴，一般每次针5~6穴。

(2) 刺激量宜强。针刺时可配合关节活动，将针退至皮下，改变针尖方向再刺。

文献参考

(1) 陈氏应用针灸加拔火罐治疗肱骨外上髁炎共96例。取穴：曲池、手三里、肘尖压痛点。针后加用艾灸，或用隔姜灸，或用皮肤针局部叩刺，然后加拔火罐，结果96例均获痊愈。(陈

朝明等:针刺治疗肱骨外上髁炎,四川中医,3(6):37,1985)

(2) 钱氏应用针灸治疗肱骨外上髁炎。取阿是穴,先针刺,再施化脓灸。治疗数例,均获痊愈。(钱明岳:针灸治疗肱骨外上髁炎,浙江中医杂志,4(6):31,1978)

66. 腱鞘囊肿

腱鞘囊肿是指附着在关节囊或肌腱鞘上的囊性肿物,常发于腕关节背面、足背等处。起病缓慢,发病部位多有外伤或慢性劳损史。肿块呈圆形或椭圆形,边界清楚,表面光滑,质软而有弹性,与皮肤无粘连,但基底固定。患者诉局部酸痛或胀痛,偶有无力感。

取穴 阿是穴

定位 患处局部。

操作方法 在囊肿正中和四周各刺1针,如梅花状,各针均须刺至囊底。得气后施以提插捻转,中刺激。留针30分钟,留针期间加用温针灸,以局部温热为度。隔日1次,10次为1个疗程。

注意事项

(1) 如囊肿初起,可用手指在囊肿上用力按压,直至挤破囊肿。亦可用叩诊锤等在囊肿上敲击,使其破裂,术后不必另加处理。

(2) 本法疗程较长,施治过程中可见囊肿逐渐变小、变硬,直至消失。

(3) 本病易复发,复发后可依前法再治,仍然有效。

文献参考

(1) 杨氏应用局部针刺加按揉法治疗腱鞘囊肿共 50 例。治疗 1 次痊愈者 28 例, 2 次痊愈者 13 例, 3 次痊愈者 9 例, 总治愈率 100%。(杨通礼: 针刺加按揉法治疗腱鞘囊肿 50 例, 新中医, (4): 35, 1984)

(2) 杨氏应用针刺局部阿是穴治疗腱鞘囊肿共 17 例。其中 13 例针刺 5~9 次后囊肿消失, 针刺 10 次后 17 例全部治愈。(杨熙萍: 针刺治疗腱鞘囊肿 17 例, 中国针灸, (3): 12, 1986)

67. 桡骨茎突部狭窄性腱鞘炎

桡骨茎突部狭窄性腱鞘炎是指腕部的拇长展肌和拇短伸肌因慢性劳损而引起肌腱和腱鞘的炎症反应, 造成肌腱变粗、腱鞘壁增厚, 以致腱鞘狭窄而影响肌腱的活动。临床表现为患者桡骨茎突部疼痛, 有时可放射至手或肩、臂部, 腕及拇指活动时加剧。握力减弱, 伸拇活动受限, 桡骨茎突部有明显压痛, 常可触及黄豆大小的压痛硬结。握拳尺屈试验阳性。

取穴 阿是穴

定位 患处局部。

操作方法 在压痛点上针刺, 直刺 0.3~0.5 寸, 得气后施以提插捻转手法, 强刺激, 并将针尖向四周作多向透刺。留针 20~30 分钟。留针期间加用温针灸, 以局部温热为度。隔日 1 次, 10 次为 1 个疗程。

注意事项

(1) 针刺时须避开血管, 以防引起血肿。

(2) 亦可应用水针疗法。在压痛点处穴位注射 0.5% 普鲁卡因 2 毫升,每周 1 次。

文献参考

某卫生所应用穴位注射疗法治疗桡骨茎突部狭窄性腱鞘炎共 52 例。在腱鞘压痛最明显处注射安痛定 2 毫升或 0.5% 盐酸普鲁卡因 2 毫升或 5~10% 葡萄糖 2 毫升。多数 1 次治愈,仅少数 2 次治愈。(吉林伊通县伊丹公社毯子大队卫生所:水针治疗拇长展肌和拇短伸肌腱鞘炎,新医药学杂志,(7): 封三, 1973)

68. 急性腰肌扭伤

急性腰肌扭伤是指腰部的肌肉和筋膜在活动时因用力不当而突然损伤,多因腰部肌肉强力收缩所引起,俗称“闪腰”。扭伤时患者常感到腰部有牵扯或撕裂感,疼痛剧烈,腰部活动受限,咳嗽、打喷嚏或用力时疼痛加剧。检查时可发现腰部肌肉紧张,有明确的压痛部位,压痛明显。X 线摄片检查可排除骨折等其他疾病。

方 一

取穴 养老

定位 在前臂背面尺侧,当尺骨小头近端桡侧凹陷中。取穴时可先使患者掌心向下,医生将食指指尖置于患者尺骨茎突上,然后使患者手掌翻转,掌心向胸,医生食指指尖下的凹陷处即是穴位(图9)。

操作方法 患者掌心向胸，沿尺骨小头桡侧缘的骨缝中向上斜刺约1寸。得气后采用提插捻转手法，强刺激，使针感经肘、肩而传至腰，同时嘱患者活动腰部，一般即觉疼痛减轻，腰部活动情况改善。留针20~30分钟。

注意事项

- (1) 先选用单侧穴位，如疗效不显时再加用双侧。
- (2) 针刺时以针感传导到腰部疗效为佳。
- (3) 本法刺激量较强，应注意防止晕针。

文献参考

(1) 《类经图翼》：“养老：疗腰重痛不可转侧，起坐艰难，及筋挛骨痹不可屈伸。”

(2) 董氏应用针刺养老穴治疗扭伤性腰痛共43例。其中38例针后5~10分钟症状完全消失，活动自如，其他5例针后症状明显减轻，仅有轻度不适，活动基本不受限制，针刺3次而愈。（董树华：针刺养老穴治疗扭伤性腰痛43例，中医杂志，(9):75,1981）

方 二

取穴 水沟(人中)

定位 在面部，当人中沟的上1/3与中1/3交点处。坐位或仰卧位取穴(图1)。

操作方法 向上斜刺，针入约0.5~1寸深。得气后施以捻转手法，强刺激，以患者泪出为度，同时嘱患者缓慢活动腰部。留针20~30分钟。

注意事项 本法刺激量较强，针刺前应向病人解释清楚。

文献参考

(1) 《通玄指要赋》：“人中除脊膂之强痛。”

(2) 赵氏以针刺水沟穴为主治疗急性腰扭伤共200例，结果全部治愈，其中针刺1次治愈者53例，针刺2~3次治愈者108例，针刺4~6次治愈者39例。(赵平原：针刺水沟穴治疗急性腰扭伤200例，陕西中医，(2)：84，1991)

69. 第三腰椎横突综合征

第三腰椎横突综合征是指因附着于第三腰椎横突的韧带、肌肉、筋膜等软组织损伤而引起腰部疼痛的症候群。临床表现以腰痛为主，时轻时重，可向臀部或大腿放散。腰部僵硬不舒，活动时或坐、站时间稍久即疼痛加剧。检查时可发现患者第三腰椎横突处有明显的压痛点，局部可触及条索状物、硬块或结节。X线检查多无明显的异常发现。

取穴 阿是穴

定位 患处局部。

操作方法 在患者第三腰椎横突处找出压痛点，压痛最明显处是穴。直刺至骨，得气后施以提插捻转手法，作多向透刺，强刺激。留针20~30分钟。出针后局部加拔火罐。隔日1次，10次为1个疗程。

注意事项

(1) 按压痛部位取穴，一般每次针5~6穴。

(2) 刺激量宜强，作大幅度提插捻转，针尖须刺在横突上。

文献参考 王氏应用局部针刺拔罐治疗第三腰椎横突综

合征共85例。结果痊愈(自觉症状及患部压痛消失,腰部活动自如)61例,好转(自觉症状基本消失或患部有轻压痛)22例,无效2例。(王本元:针刺拔罐治疗85例腰椎横突综合征,河北中医,(4):46,1985)

70. 腰 肌 劳 损

腰肌劳损是指腰骶部肌肉、韧带、筋膜等软组织的慢性损伤。患者多有急性腰部扭伤史,或有长期弯腰工作和重体力劳动等病史。临床表现以腰痛为主,病程较长,反复发作,劳累后加剧,休息后减轻,并与气候变化有关。腰部有僵硬感,但腰部活动一般无明显障碍。检查时可发现腰肌紧张,腰部压痛广泛,在两侧腰肌、髂嵴或骶骨后面可有明显压痛点。X线检查多无异常发现。

取穴 阿是穴

定位 患处局部。

操作方法 在腰部寻找压痛点,在压痛点上针刺,直刺约2~3寸,得气后施以提插捻转手法,强刺激,并将针尖向四周作多向透刺。留针20~30分钟。留针期间加用温针灸,针后加拔火罐。每日或隔日1次,10次为1个疗程。

注意事项

(1) 按压痛点取穴,一般每次针5~6穴。

(2) 亦可应用水针疗法。在压痛点处穴位注射0.5%普鲁卡因2毫升,每周1次。

文献参考 林氏应用穴位封闭疗法治疗急、慢性腰肌劳

损,选用阿是穴,药物系地塞米松、654-2、当归液和奴夫卡因的混合液,共治疗数百例,均获满意疗效。(林钦安:穴位封闭治疗急、慢性腰肌劳损,中国乡村医生,(12):30,1987)

71. 梨状肌综合征

梨状肌综合征是指因梨状肌充血、水肿、痉挛、肥厚等刺激或压迫坐骨神经而引起的症候群。患者多有外伤史,以臀部疼痛和坐骨神经痛为主要症状,腰部无明显压痛,活动正常。在梨状肌处有明显压痛和放射痛,梨状肌痉挛、肿胀或肥厚,可触及条索状物,沿坐骨神经可有压痛,直腿抬高试验阳性。

取穴 阿是穴

定位 患处局部。

操作方法 在压痛点上针刺,直刺约2~3寸,得气后施以提插捻转手法,强刺激,并将针尖向四周作多向透刺。留针20~30分钟。针后加拔火罐。隔日1次,5次为1个疗程。

注意事项

(1) 刺激量宜大,可采用多针齐刺。

(2) 拔火罐时以针孔微有出血为度。

(3) 亦可应用水针疗法。在压痛点处穴位注射0.5%普鲁卡因4~6毫升,每周1次。

文献参考 包氏应用刺血疗法治疗梨状肌损伤综合征共35例。先用皮肤针局部叩刺,待皮肤微出血时,加拔火罐,然后在委中穴点刺出血。隔日1次,7次为1疗程。结果痊愈20例,显效11例,好转4例。治疗次数最少者3次,最多者14次,一般

3~7次即可控制疼痛。(包贵兆:刺血治疗梨状肌损伤综合征35例,陕西中医,(2):57,1990)

72. 髌下脂肪垫损伤

髌下脂肪垫损伤是膝关节的常见疾患,多见于运动员或膝关节活动较多的体力劳动者。患者自觉膝部疼痛,并有酸胀无力感,劳累后症状加重,休息后减轻。疼痛部位在髌韧带上端后方及其两侧,局部可有肿胀或膨隆,压痛明显。关节过伸运动受限,伸膝抗阻力试验多为阳性。

取穴 阿是穴

定位 患处局部。

操作方法 取患侧穴位。在髌韧带上及其两侧膝眼处寻找压痛点,以压痛最明显处是穴。直刺约1~1.5寸,得气后施以提插捻转手法,强刺激,并将针尖向四周透刺。留针20~30分钟。留针期间加用温针灸。隔日1次,10次为1个疗程。

注意事项

亦可应用水针疗法,在压痛点处穴位注射0.5%普鲁卡因2~4毫升,每周1次。

73. 足 跟 痛

足跟痛是常见的临床症状,多为双侧,行走时加重,甚至无法走路或站立。引起足跟痛的原因很多,除了跟骨骨折、结

核、肿瘤、骨髓炎、骨髓炎、痛风等疾病外，由跟腱炎、跟部滑囊炎、足跟脂肪纤维垫炎、跖腱膜炎、跟骨骨刺等所引起的足跟痛最为多见。

方 一

取穴 阿是穴

定位 患处局部。

操作方法 取患侧穴位。先用手按压患者足跟，找出最痛之压痛点，常规消毒后，医生左手固定患处，右手持针快速刺入。得气后，施以大幅度提插捻转手法，并将针尖向四周透刺，持续1~2分钟。留针15~20分钟后起针。

注意事项

(1) 如痛处范围较大，可出针后寻找压痛点再刺。

(2) 本法疗效较好，一般即刻可觉症状减轻，但刺激量较强，施用前应向病人解释清楚。

文献参考 彭氏应用穴位注射阿是穴治疗足跟部滑囊炎共18例。每次选3~5穴，注入2%普鲁卡因2~4毫升和强的松龙1~2毫升。结果治愈(局部肿胀完全消失，功能活动恢复正常)17例，其中，经1次治愈者3例，2次治愈者5例，3次治愈者8例，4次治愈者1例。显效(局部疼痛基本消失，功能活动与健侧稍有差异)1例。(彭启琼：穴位注射治疗足跟部滑囊炎18例，中西医结合杂志，(1)：56，1988)

方 二

取穴 大陵

定位 在腕部,当腕掌侧横纹之中点处,即当桡侧腕屈肌腱与掌长肌腱之间的凹陷处(图8)。

操作方法 取患侧或双侧穴位,直刺约1寸左右,得气后施以大幅度提插捻转手法,刺激强度以病人能够忍受为度,时间1~2分钟,同时嘱病人行走或站立作跺脚动作。留针20~30分钟。

注意事项

- (1) 取穴时大陵穴处有压痛者疗效较好。
- (2) 一般针刺时即可觉足跟痛有所减轻。如遇复发,可依前法再刺。
- (3) 留针期间应反复行针。

文献参考 赵氏应用针刺大陵穴治疗跟骨骨刺共67例。边施针刺手法,边震跺患足足跟,每日1次,10次为1个疗程。结果痊愈(经治疗1~2个疗程,患处疼痛消失,走路无不适,随访2~7年无复发)50例,占74%;显效(疼痛消失,活动良好,但有反复,经用前法治疗仍有效)12例,占18%;有效(疼痛基本消失,但活动或持重时仍稍有痛感)4例,占6%;无效(经治疗1~2个疗程后,患处疼痛稍有减轻,但后又改为手术治疗)1例。(赵怀儒:针灸治疗67例跟骨骨刺的疗效观察,河北中医,(4):47,1985)

74. 软 组 织 损 伤

软组织损伤是指肌肉、肌腱、韧带、筋膜、神经、血管、软骨等软组织因各种直接或间接因素而造成的损伤。根据病程长短可分为急性软组织损伤与慢性软组织损伤两类,但均无骨

折、脱位或皮肉破损。一般多有明显的外伤史,局部可以找到明显的压痛点。急性软组织损伤局部肿胀、疼痛,肌肤可见青紫,并伴有相应关节活动功能障碍。慢性软组织损伤则以疼痛和功能障碍为主,局部肿胀不明显,常因气候变化或劳累而反复发作。本病属于中医“伤筋”的范畴。

取穴 阿是穴

定位 患处局部。

操作方法 在损伤局部寻找压痛点,在压痛点上针刺,并根据病变部位决定针刺深浅。得气后施以提插捻转手法,强刺激,并将针尖向四周作多向透刺,然后将针提至皮下,按压局部继续寻找压痛点,找到后仍按原法施治,直至局部无压痛点为止。留针20~30分钟。针后可加拔火罐。

注意事项

(1) 针刺时必须将压痛点逐一消除,不可有所遗漏,否则疗效不佳。

(2) 本法对各种慢性软组织损伤疗效较好,一般1次即可见效。对急性软组织损伤往往须治疗多次。

(3) 如患处局部已施行过封闭治疗则疗效较差。

文献参考

(1) 《灵枢·经筋》:“治在燔针劫刺,以知为数,以痛为输。”

(3) 卢氏等应用阿是穴治疗腰背和四肢肌肉急性或慢性损伤患者共315例,沿受伤肌肉长轴针刺,不提插捻转。结果痊愈199例,显效111例,好转5例。(卢鼎厚等:斜刺对骨骼肌损伤的治疗作用,中国针灸,9(6):1,1989)

75. 疼 痛

疼痛是临床上常见的症状,许多疾病均可发生,有时并且作为主要症状出现,称为疼痛综合征。按其疼痛程度一般可分为轻度、中等、剧烈和难以忍受四种类型。轻度疼痛仅引起不适,持续疼痛时可影响饮食、睡眠和精神状态,而剧烈的疼痛则会造成病人极大的痛苦。疼痛虽然是一种令人不快的感觉和情绪上的感受,但往往伴有现存的或潜在的组织损伤。

取穴 耳穴

定位 耳廓上病变的相应部位。

操作方法 根据病变在患者耳廓上的相应部位寻找压痛点,以压痛最明显的一点作为穴位。针刺深度以刺入软骨但不刺穿对面皮肤为度,得气后施以捻转手法。患者局部可有疼痛、热、胀、酸、麻等感觉,留针15~30分钟。

注意事项

(1) 须仔细寻找压痛点,以压痛最明显的一点作为穴位。针刺时位置必须准确,否则疗效较差。

(2) 针刺耳穴刺激较强,如患者无法接受,亦可采用局部王不留行埋籽法,并嘱患者自行按压埋籽处。

76. 痛 经

痛经是指月经期间或其前后发生的腹痛而言。凡月经初

潮即发生痛经,生殖器官无明显性病变者,称为原发性痛经;如月经初潮时并无痛经,以后因生殖器官器质性病变导致痛经者,称为继发性痛经。疼痛一般发生在月经前数小时,呈阵发性痉挛性疼痛。常伴有面色苍白、出冷汗、手足发凉、恶心、呕吐、腹泻、腰酸等症状。

取穴 十七椎

定位 在腰部,当后正中线上,第5腰椎棘突下(图6)。

操作方法 向上斜刺,进针约1.5寸左右。得气后施以提插捻转手法,强刺激。留针 15~20 分钟。

注意事项 施治时刺激量宜强,使针感扩散,如针感到达侧腹或少腹部则疗效较佳。

文献参考

(1) 阎氏应用本法治疗痛经 22 例,痊愈 18 例(一般治疗 1~3 次),显效 2 例,无效 2 例。(阎洪臣等:针刺“十七椎下”穴为主治疗痛经、经闭,上海中医药杂志,(12):30,1965)

(2) 骆氏应用本法治疗痛经 64 例。痊愈(针后半分至 3 分钟内疼痛减轻或消失,留针 10 分钟后面色转红,腹痛消失) 59 例,显效(针后疼痛虽减轻,但未完全消失) 4 例,无效(针后疼痛无减轻) 1 例。(骆方:针刺十七椎治疗原发性痛经 64 例,浙江中医杂志,(8):379,1988)

77. 胎 位 不 正

胎位不正是指妊娠 28 周后,胎儿在子宫体内的位置不正而言。常见于经产妇或腹壁松弛的孕妇。临床上多无自觉症

状,经产前检查才能明确诊断。一般有枕后位、臀位、横位、斜位等。如不及时纠正,分娩时可能造成难产。

取穴 至阴

定位 在足小趾末节外侧,当外侧趾甲角与趾腹外侧缘连线之中点处,距趾甲角0.1寸(指寸)(图10)。

操作方法 治疗前孕妇应排空小便,松解腰带,取靠背坐位或仰卧位,暴露双足,双侧至阴穴同时用艾条施以温和灸,以局部有温热感而无灼痛为度。每次20~30分钟。每日1~2次。7日为1个疗程。

注意事项

(1) 至阴穴宜灸不宜针,针刺后可引起宫缩,应引起注意。

(2) 胎位不正原因很多,如因骨盆狭窄、子宫畸形等引起者,应作其他处理。

文献参考

(1) 江西省艾灸矫正胎位研究组应用艾灸至阴穴治疗胎位不正共100例。成功71例,失败29例,成功率71%。成功者大部分于艾灸1~3次后生效,计灸1次胎位转正者24例,2次17例,3次13例,4~5次9例,6~7次5例,8~9次3例。(江西省艾灸矫正胎位研究组:艾灸至阴穴矫正胎位的临床观察及原理探讨,中医杂志,(8):9,1979)

(2) 灸法矫正胎位协作组应用艾灸至阴穴矫正胎位不正共2069例。取双侧至阴穴,用艾条温和灸,以不产生灼痛为限,每日1次,每次15分钟。结果成功者1969例,占90.3%。其中86%治疗1~4次即矫正,14%于5~10次后矫正。(灸法矫

正胎位协作组: 艾灸至阴穴矫正胎位的研究, 全国针灸针麻学术讨论会论文摘要(一), 4页, 1979)

78. 百 日 咳

百日咳是由百日咳杆菌引起的急性呼吸道传染病, 多发于冬、春二季。起病时先有上呼吸道卡他症状, 以后则咳嗽加重, 而全身症状较轻。其特征为阵发性痉挛性咳嗽, 咳嗽终止时出现鸡鸣样吸气吼声。本病多见于婴幼儿, 病程可持续3~4个月之久, 故有百日咳之称。中医称“顿咳”。

取穴 四缝

定位 在两手第2~5指的掌面, 指间关节横纹之中点处, 一侧4穴(图8)。

操作方法 取双侧穴位。常规消毒后, 用三棱针点刺, 挤出少量黄白色粘液或使出血。每周1次, 5次为1个疗程。

注意事项

(1) 点刺应迅速、准确。术后可用消毒棉球在穴位上按压片刻。

(2) 点刺时以刺出黄色粘液为佳。如仅有出血, 则疗效较差。

文献参考 顾氏应用针刺四缝穴治疗小儿百日咳共112例。其中痊愈82例, 占73.2%; 显效21例, 占18.8%; 无效9例, 占8.3%。(顾天培: 针刺治疗小儿百日咳112例临床观察, 中医杂志, 24(2): 51, 1983)

79. 婴幼儿腹泻

婴幼儿腹泻是指以腹泻为主症的胃肠道功能紊乱综合征。由于小儿消化系统发育不成熟,加上喂养不当、受凉或过热,以及肠道内、外感染等因素即可引起发病,以夏秋季多见。临床上常根据腹泻的轻重将其分为轻型腹泻和重型腹泻两种类型。轻型腹泻一般仅有腹泻症状,重型腹泻则腹泻每日达10次以上,并伴有发热、呕吐以及水和电解质紊乱症状。如腹泻病程过长,常易并发营养不良、各种维生素缺乏症、贫血、呼吸道继发感染等疾病。

方 一

取穴 足三里

定位 在小腿前外侧面的上部,犊鼻穴下3寸,距胫骨前缘1横指(中指)(图10)。

操作方法 取双侧穴位。用30号1寸毫针,直刺约0.5寸深,施以大幅度提插捻转手法,强刺激,不留针。每日或隔日1次。3次为1个疗程。

注意事项 进针应迅速,刺激量宜强,施行手法后即起针。

文献参考

(1) 陈氏应用针刺足三里穴治疗小儿腹泻共18例,均获治愈。(陈全新:针刺治疗小儿腹泻的初步报告,广东中医,(6):16,1985)

(2) 张氏等应用针刺足三里穴治疗婴幼儿腹泻共32例。结果显效(针刺1次大便次数即恢复正常)20例;有效(针刺2次大便次数恢复正常)10例;无效(针刺2次以上大便次数减少不明显)2例。(张炳秀等:足三里针治婴幼儿腹泻32例报道,安徽中医学院学报,(3):36,1988)

方 二

取穴 四缝

定位 在两手第2~5指的掌面,指间关节横纹之中点处,一侧4穴(图8)。

操作方法 取双侧穴位。常规消毒后,用三棱针点刺,挤出少量黄白色粘液或使之出血。每周1次,5次为1个疗程。

注意事项

(1) 点刺应迅速、准确,术后可用消毒棉球在穴位上按压片刻。

(2) 点刺时以刺出黄色粘液为佳。

文献参考 熊氏应用针刺四缝配合捏脊治疗婴幼儿消化不良性腹泻共108例。治愈102例(94.4%),好转5例(4.7%),无效1例(0.9%)。(熊新安:针四缝配合捏脊治疗婴幼儿消化不良性腹泻108例,陕西中医,5(5):19,1984)

80. 疳 积

疳积是以面黄肌瘦、毛发焦枯、精神萎靡、食欲不振或饮食反常、腹部膨胀、发育迟缓等为主要症状的一种慢性病证。

现代医学称之为“营养不良”，多见于5岁以下的婴幼儿。摄食不足或食物不能充分吸收利用，或慢性疾病消耗过大而未能补充，均可导致本病。

取穴 四缝

定位 在两手第2~5指的掌面，指间关节横纹之中点处，一侧4穴(图8)。

操作方法 取双侧穴位。常规消毒后，用三棱针点刺，挤出少量黄白色粘液或使之出血。每周1次，5次为1个疗程。

注意事项

(1) 点刺应迅速、准确，术后可用消毒棉球在穴位上按压片刻。

(2) 点刺时以刺出黄色粘液为佳，如仅有出血，疗效较差。

文献参考

(1) 吴氏应用点刺四缝穴治疗小儿疳积共150例。痊愈(3个月内食欲恢复正常，体重逐渐增加，皮肤弹性逐渐恢复，腹胀或凹陷消失，1年内体重和身高达到或接近正常标准)146例；好转(症状明显改善，1年后随访，体重和身高与正常小儿尚有差距)3例；无效(连续治疗3个月病情无好转)1例，总有效率99%。(吴成善：主刺四缝穴治疗小儿营养不良症，安徽中医学院学报(3)：46,1985)

(2) 金氏等应用针刺四缝穴治疗小儿疳积342例，总有效率为98.38%。(金红等：针刺四缝穴治疗小儿疳症342例临床观察，湖南中医杂志，(2)：37,1991)

81. 遗 尿

遗尿是指3周岁以上的小儿，在睡眠中经常有自主的排尿。可发生在夜间或白昼，但以夜间常见，轻者数夜1次，重者一夜多次。多与精神紧张、过度疲劳及环境变化等因素有关。经检查无泌尿系统的器质性病变。

方 一

取穴 关元

定位 在腹下部，前正中线上，当脐下3寸，曲骨穴上2寸。仰卧位取穴(图5)。

操作方法 医生左手拇指切按在穴位上，右手持针，紧靠指甲用力徐徐刺入，直刺约1寸。得气后施以捻转手法，中刺激。留针20~30分钟，留针期间加用温针灸。每日或隔日1次，10次为1个疗程。

注意事项 快速刺入皮下后，进针速度宜慢，边进针手指边向下用力，得气后，将针单方向捻转并微微上提，使下腹部有麻胀感或向前阴放射。

文献参考 卢氏应用灸关元穴为主治疗遗尿症共73例。艾炷如绿豆大小，每次灸10壮，艾炷烧至患者不能忍受即除去。结果治愈69例，显效3例，好转1例。治疗次数最少3次，最多30次。(卢诗雅：灸关元穴为主治疗遗尿症，广东中医，(5):30,1963)

方 二

取穴 阿是穴

定位 腰骶部压痛点。

操作方法 在腰骶部寻找反应点，一般靠近脊柱两侧多有压痛点或阳性反应物。直刺或沿皮刺，刺入约1寸，得气后施以提插捻转手法，中刺激。留针20~30分钟，针后加拔火罐。每日或隔日1次，10次为1个疗程。

注意事项 亦可应用水针疗法。在压痛点处穴位注射生理盐水或0.5%普鲁卡因2毫升，每周1次。

82. 近 视

近视是一种视力减退的病症。指在眼不用调节的情况下，平行光线经过眼的屈光系统屈折后，其焦点位于视网膜之前。患者视远物时模糊，但视近物时清楚，常眯目视物，阅读距离比正常近，并常有眼前飞蝇、飞蚊等幻视感。

方 一

取穴 睛明

定位 在面部，目内眦角稍上方凹陷处。坐位或仰卧位取穴(图1)。

操作方法 病人闭目仰卧。医生左手轻推眼球向外侧固定，右手持32号1.5寸毫针，缓慢进针，直刺约1寸。得气后

施以捻转手法,中刺激。留针30分钟。隔日1次,10次为1个疗程。

注意事项

(1) 进针应缓慢,不宜用提插手法。进针过程中如病人感觉疼痛,表明刺伤血管,应将针退出少许,稍变换方向再刺入。

(2) 出针后应在针孔按压片刻,以防出血。

文献参考 于氏应用针刺睛明穴治疗青少年近视 67 例,均深刺1~2寸,不用提插捻转手法,总有效率为91.3%。(于莉莉:深刺睛明穴治疗青少年近视 67 例,针灸学报,(4):39,1989)

方 二

取穴 颈部夹脊

定位 第3颈椎至第7颈椎,各椎棘突下旁开0.5寸。

操作方法 在颈椎棘突两侧寻找压痛点,直刺约1寸左右,得气后施以提插捻转手法,中刺激。留针20~30分钟。隔日1次,10次为1个疗程。

注意事项

(1) 针刺时病人须闭上眼睛,全身放松。

(2) 针尖须直刺至骨,不可向内侧斜刺,以免伤及脊髓。

83. 目赤肿痛

目赤肿痛为临床上常见的症状,俗称“红眼”,可见于多种

眼病,如急性结膜炎、流行性出血性结膜炎、流行性角膜结膜炎等。患者多突然发病,自觉一眼或双眼痒痛不适,有灼热或异物感,结膜充血显著,并伴有怕光、流泪、眼分泌物增多、眼睑肿胀等症状。属于中医“天行赤眼”、“暴发火眼”等病的范畴。

取穴 太阳

定位 在颞部,当眉梢与目外眦之间,向后约1横指的凹陷处(图3)。

操作方法 取双侧穴位。用细三棱针快速点刺穴位,使出血数滴。

注意事项 点刺前可先在穴位局部揉按片刻,使之易于出血。

文献参考 《针灸大成》:“太阳:治眼红肿及头。”

84. 耳 鸣

耳鸣是常见的听觉异常症状,患者自觉耳内作响,但周围并无相应的声源,而且越安静感觉鸣声越大。通常分自觉性耳鸣和他觉性耳鸣两种,以自觉性耳鸣最为多见。

方 一

取穴 听会

定位 在面部耳前方,当耳屏间切迹前方与下颌骨髁状突的后缘,张口有凹陷处,可摸到颞浅动脉搏动(图3)。

操作方法 取患侧穴位,如双耳耳鸣则取双侧穴位。直刺约1~1.5寸,得气后施以捻转手法,中刺激。留针20~30分钟。隔日1次,10次为1个疗程。

注意事项 针刺不可过深,亦不宜作大幅度提插手法,以免刺伤血管、神经。

文献参考 《百证赋》:“耳中蝉噪有声,听会堪攻。”

方 二

取穴 颈部夹脊

定位 第3颈椎至第7颈椎,各椎棘突下旁开0.5寸。

操作方法 在颈椎棘突两侧寻找压痛点,多位于第3颈椎棘突两侧。直刺约1寸左右,得气后施以提插捻转手法,中刺激。留针20~30分钟。隔日1次,10次为1个疗程。

注意事项

- (1) 针刺时针尖须直刺至骨。
- (2) 不可向内侧斜刺,以免伤及脊髓。

85. 鼻 塞

鼻塞是临床上常见的一种症状。可见于多种鼻疾病,如各种急、慢性鼻炎,急、慢性鼻窦炎,鼻部肿瘤等。常见呼吸道疾病如感冒、流行性感冒,急、慢性支气管炎等亦可引起鼻塞。本病常伴有流涕、嗅觉障碍、头痛、头昏等其他症状。

方 一

取穴 迎香

定位 在面部,鼻翼外缘中点旁,当鼻唇沟中(图1)。

操作方法 取双侧穴位。先直刺刺入迎香穴皮下后,再沿鼻唇沟向内上横刺,进针约1寸左右,得气后施以捻转手法,中刺激。留针30分钟。

注意事项 本法刺激量较强。一般即刻可觉症状缓解,鼻部通气功能改善。

文献参考

(1)《铜人腧穴针灸图经》:“迎香:治鼻有息肉,不闻香臭,衄血,……”

(2)《针灸大成》:“迎香:主鼻塞不闻香臭,……”

(3)宿氏等应用深刺迎香穴治疗慢性鼻窦炎共10例。刺入1~1.5寸,针尖达下鼻甲前下端。每日1次,2~5次为1个疗程。结果痊愈(症状消失,嗅觉灵敏,呼吸通畅,不复发者)8例;显效(症状基本消失)1例;无效(症状基本消失,略有鼻塞感)1例,最短者3次痊愈,最长者12次。(宿享禄等:深刺迎香穴治疗慢性鼻窦炎10例,中国针灸,(5):16,1984)

方 二

取穴 印堂

定位 在面部,当两眉之间中点处,正对鼻尖(图1)。

操作方法 医生左手拇、食二指将患者印堂穴处皮肤捏

起,右手持针从捏起的皮肤上端刺入,针尖向下刺至鼻根部。得气后施以捻转手法,强刺激。留针30分钟。

注意事项

- (1) 出针后应用消毒棉花按揉针孔片刻,以防出血。
- (2) 本法可同时改善头痛、头昏等症状。

文献参考

林氏应用深刺印堂穴治疗过敏性鼻炎共30例。针尖向下沿皮下刺入约1寸,使针感外达鼻准,内及鼻腔。每日或隔日1次,10次为1个疗程。结果基本治愈(临床症状消失,半年以上不复发)12例;显效(临床症状基本消失,偶而受致敏原刺激,有轻微鼻塞或流少许清涕,但短时自愈)11例;进步(气候变化或其他因素刺激,复发次数减少,症状减轻,并较快控制)6例;无效(针刺3次不见效果)1例。总有效率达96.7%。(林凌:深刺印堂穴治疗过敏性鼻炎的体会,新中医,(2):28,1985)

86. 鼻 衄

鼻衄,即鼻出血,是一种常见症状,可发生于任何年龄及季节。鼻衄原因可分为局部和全身两大类,前者如外伤、鼻腔和鼻窦的各种急慢性炎症、鼻肿瘤,后者则包括急性传染病、心血管疾病、血液病、肝、脾、肾的慢性疾病以及维生素C或K的缺乏等,轻者仅涕中带血,重者可出血不止,引起贫血和出血性休克。出血部位大多在鼻中隔前下方的易出血区,老年人则以鼻腔后部较为多见。

方 一

取穴 迎香

定位 在面部,鼻翼外缘中点旁,当鼻唇沟中(图1)。

操作方法 取双侧穴位。先直刺刺入迎香穴皮下后,再沿鼻唇沟向内上横刺,进针约1寸左右,得气后施以捻转手法,中刺激。留针30分钟。

注意事项 留针期间应每隔3~5分钟行针1次。

文献参考

(1)《铜人输穴针灸图经》:“迎香:治鼻有息肉,不闻香臭,衄血,……”

(2)吴氏应用针刺迎香穴治疗鼻衄共50例,痊愈45例,治愈率为90%。(吴成善:针刺迎香穴治疗鼻衄,四川中医,(2):35,1985)

方 二

取穴 涌泉

定位 在足底部,卷足时足前部凹陷处,约当足底2、3趾趾缝纹头与足跟连线的前1/3与后1/3交点上(图13)。

操作方法 取双侧穴位。直刺约1寸,得气后施以大幅度提插捻转,强刺激。留针20~30分钟。

注意事项 亦可用艾条在涌泉穴施以温和灸,或用蒜泥在涌泉穴贴敷。

文献参考

(1) 《千金翼方》：“鼻衄不止，灸涌泉二穴百壮。”

(2) 《串雅》：“鼻血不止，蒜一枚去皮捣如泥，作饼子如钱大。左鼻出血贴左足心，右鼻出血贴右足心，两鼻俱出俱贴之，立瘥。”

87. 咽喉肿痛

咽喉肿痛是咽喉部病变的常见症状之一。属于中医的“喉痹”、“乳蛾”等范畴。临床表现以咽痛、咽干、吞咽不利为主。急性者往往伴有发热、口渴、便秘等全身症状，慢性者可有咽部异物感。引起咽喉肿痛的原因很多，这里主要指由于上呼吸道感染、急性扁桃体炎、急性咽炎、慢性咽炎、单纯性喉炎以及扁桃体周围脓肿等所致的咽喉肿痛。

取穴 天容

定位 在颈外侧部的上部，当下颌角的后方，胸锁乳突肌的前缘凹陷中（图3）。

操作方法 用30号2寸毫针，向舌根部方向直刺1.0~1.5寸，得气后可有胀痛感向咽喉部放散，将针提至皮下，嘱病人作吞咽动作，一般可即觉症状有所减轻。重复行针数次。留针20~30分钟。

注意事项

(1) 针刺时应避开血管。天容穴位于胸锁乳突肌与血管之间，前方有颈外浅静脉、颈内动、静脉，深层为交感神经干的颈上神经节，不宜针刺过深。

(2) 先取单侧穴位，如效果不显再加取双侧。

(3) 针在穴位深处时,嘱病人尽量不作吞咽动作。

文献参考 《铜人输穴针灸图经》:“天容:治喉痹寒热,咽中如梗”。

88. 急性扁桃体炎

急性扁桃体炎是腭扁桃体的急性感染性炎症。往往伴有程度不等与范围不一的急性咽炎。临床表现为咽痛、发热、扁桃体肿大、吞咽困难、颌下淋巴结可有肿大或压痛,实验室检查可发现血白细胞总数及中性白细胞计数升高。本病属于中医的“乳蛾”、“喉蛾”等范畴。

方 一

取穴 少商

定位 在手拇指末节桡侧,当平齐桡侧指甲角与指腹桡侧缘连线之中点处,距指甲角0.1寸(图8)。

操作方法 取双侧穴位。用三棱针快速点刺穴位,使出血数滴。

注意事项 点刺前可先在穴位局部揉按片刻,使之易于出血。

文献参考

(1) 《铜人输穴针灸图经》:“以三棱针刺之,微出血,泻诸脏热毒。唐刺史成君绰,忽腮颌肿大如升,喉中闭塞,水粒不下三日,甄权针之立愈。”

(2) 《针灸大成》:“主颌肿喉闭,……小儿乳蛾。”

(3) 《医宗金鉴》：“少商惟针双蛾痹，血出咽开功最奇。”

方 二

取穴 阿是穴

定位 患处局部。

操作方法 患者坐位，使头部固定。医者一手用压舌板压住患者舌头，一手持三棱针点刺患处局部5~10下，嘱患者吐出血性分泌物，然后用凉开水嗽口。

注意事项

(1) 点刺应手法轻快，深浅适度。

(2) 如患处已化脓，则向该处刺入。

(3) 注意口腔清洁，有条件时可用复方硼砂溶液或其他消毒液嗽口。

文献参考

(1) 宗氏应用点刺放血疗法治疗急性扁桃体炎 200 例。1 次退热 124 例，占 62%；2 次退热 76 例，占 38%；单纯针刺治愈率为 100%。（宗士纯：针刺治疗急性扁桃体炎 200 例疗效观察，河北中医，(2)：16，1988）

(2) 靳氏采用放血疗法治疗咽喉肿痛 152 例。结果治愈 119 例，占 78.3%；好转 25 例，占 16.4%；无效 8 例，占 5.3%；总有效率为 94.7%，平均治愈时间为 1.2 天。（靳新领：放血治疗咽喉肿痛 152 例，国医论坛，(1)：34，1991）

89. 慢性咽 炎

慢性咽炎是咽部粘膜、粘膜下及淋巴组织的弥漫性炎症，以咽部干燥不适为主要表现，常由急性咽炎反复发作转变而来。患者自觉咽部不适，有干燥、发痒、灼热、微痛、异物感等，干咳或咳出少量粘液，一般全身症状不明显。本病属于中医的“喉痹”、“嗑干”等范畴。

取穴 照海

定位 在足内侧面，内踝尖下方凹陷中(图12)。

操作方法 取双侧穴位。直刺约0.5寸深，得气后施以提插捻转手法，强刺激，至咽喉部有感觉时停针，留针30分钟。每日1次，7次为1个疗程。

注意事项

- (1) 针刺时嘱患者作吞咽动作，一般即刻可觉症状减轻。
- (2) 照海穴处有压痛时针刺效果最佳。

文献参考

- (1) 《针灸甲乙经》：“咽干，照海主之。”
- (2) 《铜人腧穴针灸图经》：“照海：治嗑干。”
- (3) 杜氏应用照海穴为主治疗咽喉肿痛220例。每日1次，2次为1个疗程。针刺3个疗程无效时加用配穴。其中治愈(咽喉肿痛消失，全身症状消失)195例；显效(咽喉肿痛消失，全身症状基本消失)22例；无效(咽喉肿痛及全身症状无改变)3例；总有效率为98.6%。(杜宗华：照海穴为主治疗咽喉肿痛220例)

例,陕西中医,(3):131,1988)

90. 牙 痛

牙痛是临床上常见的症状,常见于各种牙病,如龋齿、牙髓炎、牙周炎、冠周炎等,颌骨疾患、神经疾患以及一些全身疾患亦可引起牙痛。其临床表现以牙痛为主,遇冷、热、酸、甜等刺激则疼痛加重,可伴有牙龈肿胀或出血、龈肉萎缩、牙齿松动、颈淋巴结肿痛以及发热、食欲减退等症状。

方 一

取穴 合谷

定位 在手背,当第1、2掌骨间隙之中点处,或第2掌指关节与阳溪穴之间的中点处,稍靠近食指侧(图7)。

操作方法 取双侧穴位,略靠近第二掌骨取穴。直刺约1寸,得气后施以提插捻转手法,强刺激。留针20~30分钟。

注意事项

- (1) 针刺合谷穴刺激量较强,须注意防止晕针。
- (2) 合谷穴下血管丰富,应避免刺破血管而引起局部血肿。

文献参考

- (1) 《针灸甲乙经》:“齿龋痛,合谷主之。”
- (2) 耿氏以取合谷穴为主,观察了针刺疗法对急性牙髓炎、根尖周炎、冠周炎共97例的止痛效果。针刺当时完全止痛者37例,占38.2%;基本止痛者40例,占41.2%;疼痛减轻者16

例,占16.5%;无效4例,占4.1%。(耿温琦:针刺疗法对于急性牙髓炎、根尖周炎、冠周炎的止痛效果,中华口腔科杂志,(3):175,1959)

方 二

取穴 阿是穴

定位 患处局部。

操作方法 在颌面部相当于牙痛部位寻找压痛点,直刺约0.5寸,得气后施以捻转手法,中刺激。留针20~30分钟。

注意事项

(1) 针刺时须在牙齿根部取穴,针尖须刺达牙根深部,不可误入口腔。

(2) 如效果不显,可采用多针齐刺。

文献参考 李氏等应用针刺阿是穴加服用中药治疗牙痛共410例。治愈率达100%。(李景文等:针药治疗牙痛410例,吉林中医药,(5):22,1990)

91. 舌 强

舌强是指舌头强痛、活动不利而言,多伴有言语障碍。中医称为“舌蹇语涩”。可见于中风等脑内病损所致的后遗症。

取穴 金津、玉液

定位 在口腔内,舌下系带两侧静脉上,左为金津,右为

玉液(图4)。

操作方法 患者张口伸舌，医生左手用消毒药棉挟住舌头，使之固定，右手持针，直刺1~1.5寸。得气后施以捻转手法，中刺激。留针20~30分钟。隔日1次，7次为1个疗程。

注意事项

- (1) 针刺时应避开静脉。
- (2) 不宜针刺过深。
- (3) 不宜采用提插手法。

文献参考 《针灸大成》：“舌强难言：金津、玉液、廉泉、风府。”

附录

1. 本书所用穴位图

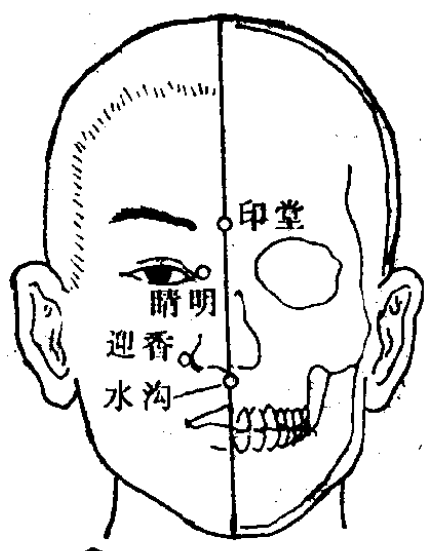


图 1

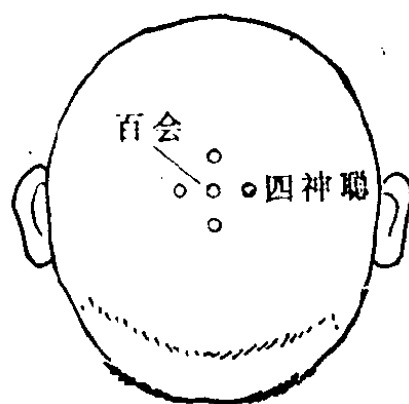


图 2

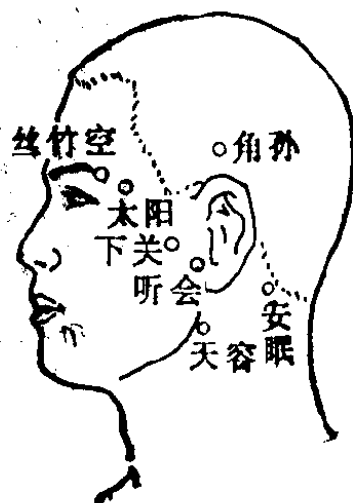


图 3

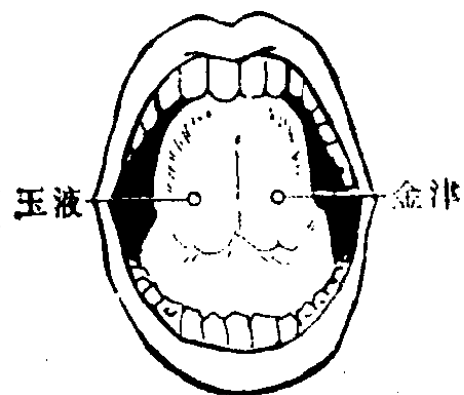


图 4

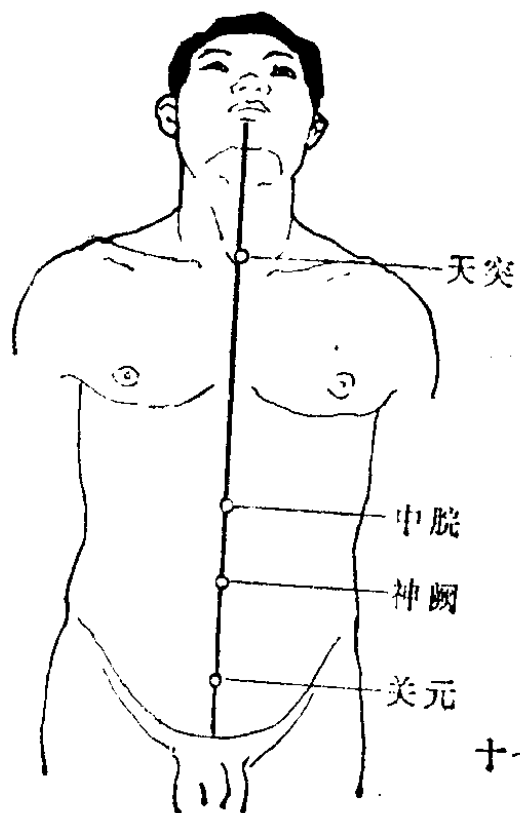


图 5

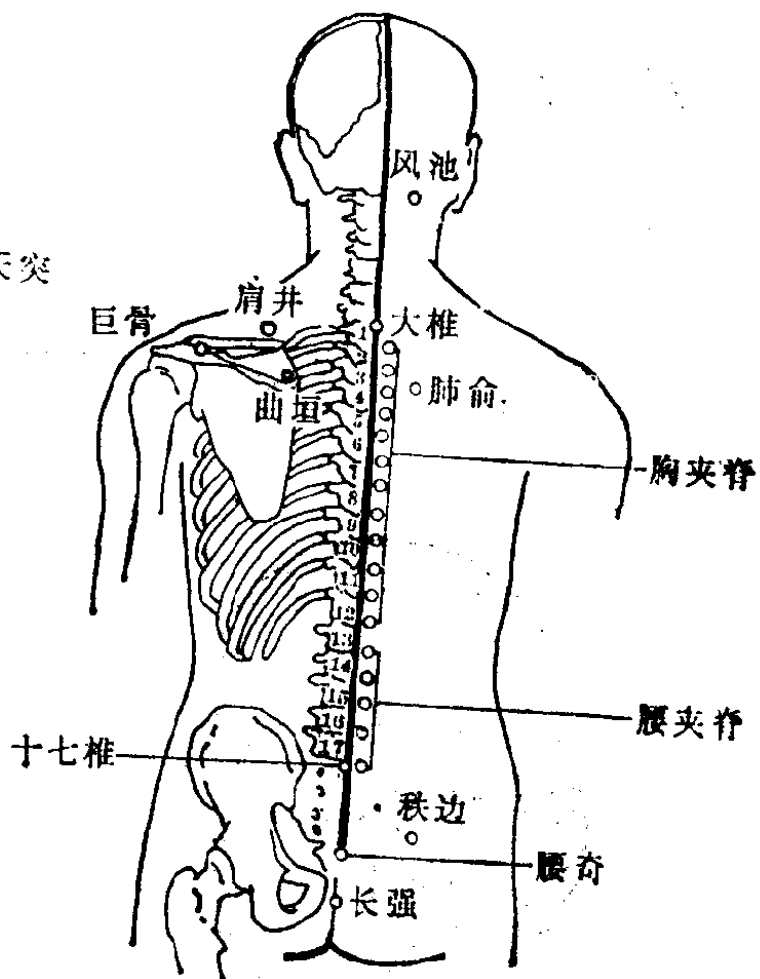


图 6

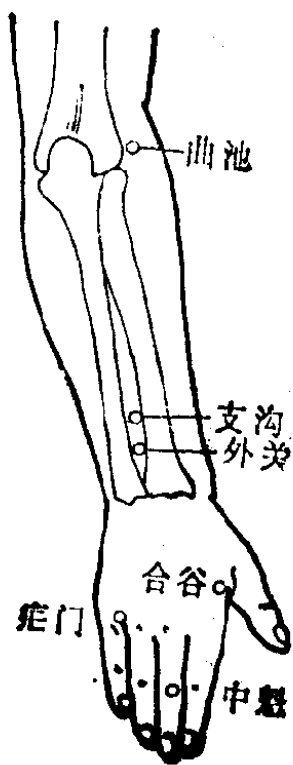


图 7



图 8

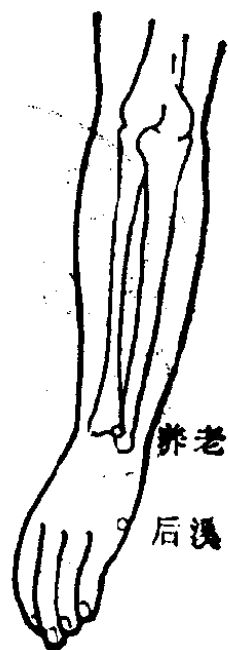


图 9

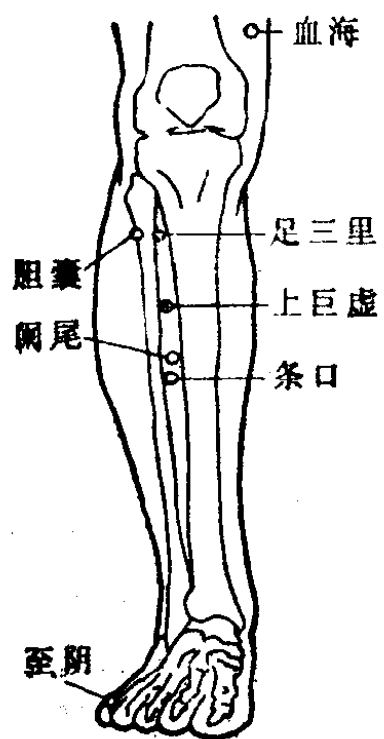


图 10



图 11

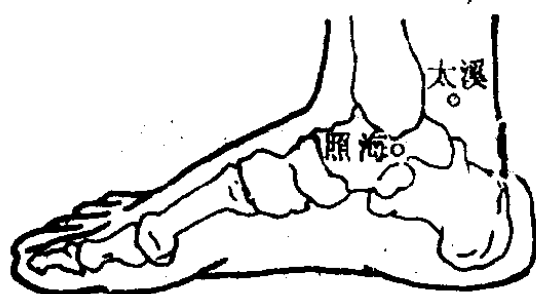


图 12



图 13

2. 常用针灸歌赋

(1) 四 总 穴 歌

《四总穴歌》最早见于明徐凤的《针灸大全》，其后《针灸聚英》、《针灸大成》等亦加转载，但均未署明出处，其作者和产生年代已不可考。全歌虽仅20字，但已将足三里、委中、列缺和合谷四个常用穴位的主治作了极简练的归纳和概括：足三里主治腹部，委中主治腰背部，列缺主治头项部，合谷主治头面部。穴在四肢而能治头部和躯干部的疾患，且主治区域各有不同，充分体现了经络理论对针灸临床的指导作用，也反映了穴位的相对特异性和针灸远道取穴治疗病患的特色。取名“四总穴”，是指全身穴位统属于这四个穴位。后世有人更在此歌后加上“胸胁若有病，速与内关谋”一句，称作《五总穴歌》；又有修改成“胸胁取内关，少腹三阴谋”，则成为《六总穴歌》，这虽不像《四总穴歌》那样脍炙人口，广为流传，但亦说明此歌对针灸临床的重要指导价值。

肚腹**三里**留，腰背**委中**求。头项寻**列缺**，面口**合谷**收。

(2) 马丹阳天星十二穴主治杂病歌

此歌诀最早见于明徐凤的《针灸大全》。系由元王国瑞《扁鹊神应针灸玉龙经》中的《天星十一穴歌诀》演变而来，除增加太冲一穴外，文字上亦略有差异。明高武《针灸聚英》中则引

作《薛真人天星十二穴歌》，其按语云：“右十二穴，薛氏以为扁鹊所传，……盖薛氏之依托也。”所说“扁鹊所传”当是指其出于《扁鹊神应针灸玉龙经》。原十一穴歌词是以《铜人输穴针灸图经》为据，太冲穴歌词则引用了金末窦汉卿著作中的语句，说明此歌虽出道家所传，但非马丹阳所作。全歌诀共910字，计总歌一首，各穴分歌十二首。所选穴位包括足三里、内庭、曲池、合谷、委中、承山、昆仑、环跳、阳陵泉、通里、列缺、太冲，均是临床上常用有效的穴位。

三里、内庭穴，曲池、合谷接。委中配承山，太冲、昆仑穴。环跳与阳陵，通里并列缺。合担用法担，合截用法截①。三百六十穴，不出十二诀②。治病如神灵，浑如汤③泼雪。北斗降真机，金锁教开彻。至人可传授，匪人莫浪说。

其一

三里膝眼下，三寸两筋间。能通心腹胀，善治胃中寒。肠鸣并泄泻，腿肿膝酸痛。伤寒羸瘦损，气虚及诸般。年过三旬后，针灸眼便宽。取穴当审的，八分三壮安。

其二

内庭次指外，本属足阳明。能治四肢厥，喜静恶闻声。耳鸣咽喉痛，数欠④及牙疼。疟疾不能食，针着便惺惺⑤（针三分，灸三壮）。

其三

曲池拱手取，屈肘骨边求。善治肘中痛，偏风手不收。挽弓开不得，筋缓莫梳头。喉闭促欲死，发热更无休。遍身风痹癰，针着即时瘳⑥（针五分，灸三壮）。

其四

合谷在虎口，两指歧骨间。头疼并面肿，疟病热还寒。齿齲鼻衄血，口噤不开言。针入五分深，令人即便安（灸三壮）。

其五

委中 曲腓里，横纹脉中央。腰痛不能举，沉沉引脊梁。酸疼筋莫展，风痹复无常。膝头难伸屈，针入即安康(针五分，禁灸)。

其六

承山 名鱼腹，腓肠分肉间。善治腰疼痛，痔疾大便难。脚气并膝肿，展转战痛酸。霍乱转筋急，穴中刺便安(针七分，灸五壮)。

其七

太冲 足大指，节后二寸中。动脉知生死，能医惊痫风。咽喉并心胀，两足不能行。七疝偏坠肿，眼目似云蒙。亦能疗腰痛，针下有神功(针三分，灸三壮)。

其八

昆仑 足外踝，跟骨上边寻。转筋腰尻痛，暴喘满冲心。举步行不得，动足即呻吟。若欲求安乐，须于此穴针(针五分，灸三壮)。

其九

环跳 在髀枢，侧卧屈足取。折腰莫能顾，冷风并湿痹。腿胯连膂痛，转折重唏嘘。若人针灸后，顷刻病消除(针二寸，灸五壮)。

其十

阳陵 居膝下，外膝一寸中。膝肿并麻木，冷痹及偏风。举足不能起，坐卧似衰翁。针入六分止，神功妙不同(灸三壮)。

其十一

通里 腕侧后，去腕一寸中。欲言声不出，懊恼及怔忡。实则四肢重，头腮面颊红。虚则不能食，暴暗面无容。毫针微微刺，方信有神功(针三分，灸三壮)。

其十二

列缺 腕侧上，次指手交叉。善疗偏头患，遍身风痹麻。痰涎频上壅，口噤不开牙。若能明补泻，应手疾如拿(针三分，灸五壮)。

【注释】

①担、截：担，指两穴同用；截，指独取一穴。

②诀：穴位。

③汤：热水。

④数欠：屡屡呵欠。

⑤惺惺：清醒，这里指疾病痊愈。

⑥瘳，病愈。

(3) 通玄指要赋

《通玄指要赋》为金代针灸医家窦汉卿所撰。首载于《针经指南》一书中。《标幽赋》偏重于对针灸理论进行阐述，而《通玄指要赋》则侧重于介绍窦氏临证针灸取穴的经验。全赋共45句，634字。计50证。除2证取2穴外，其余各证均取单穴，共计取穴49个。此赋《针灸大全》、《针灸聚英》、《针灸大成》等书均加以转载，杨继洲还为之作了注解。明代针灸医家凌汉章更在《通玄指要赋》的临证取穴基础上，加以相应的配穴，撰成《卧岩凌先生得效应穴针法赋》，每证2穴，临床亦颇具参考价值。

必欲治病，莫如用针。巧运神机之妙，工开圣理之深。外取砭针，能蠲①邪而辅正；中含水火，善回阳而倒阴。

原夫络别支殊，经交错综。或沟渠溪谷以歧异，或山海丘陵而隙共。斯流派以难揆②，在条纲而有统。理繁而昧，纵补泻以何功；法捷而明，曰迎随而得用。

且如行步难移，太冲最奇。人中除脊臂之强痛，神门去心性之呆痴。风伤项急，始求于风府；头晕目眩，要觅于风池。耳闭须听会而治也，眼痛则合谷以推之。胸结身黄，取涌泉而即可；脑昏目赤，泻攒竹以便宜。但见两肘之拘挛，仗曲池而平扫；四肢之懈惰，凭照海以消除。

牙齿痛，**吕细**堪治；头项强，**承浆**可保。**太白**宣导于**气冲**，**阴陵**开通于**水道**。腹膨而胀，夺**内庭**兮休迟；筋转而疼，泻**承山**而在早。

大抵脚腕痛，**昆仑**解愈；股膝疼，**阴市**能医。痛发癫狂兮，凭**后溪**而疗理；症生寒热兮，仗**间使**以扶持。**期门**罢胸满血膨而可已，**劳宫**退胃翻心痛以何疑。稽夫**大敦**去七疝之偏坠，王公谓此；**三里**却五劳之羸瘦，华佗言斯。

固知**腕骨**祛黄，**然谷**泻肾。**行间**治膝肿目疾，**尺泽**去肘疼筋紧。目昏不见，**二间**宜取；鼻塞无闻，**迎香**可引。**肩井**除两臂难任，**丝竹**疗头疼不忍。咳嗽寒痰，**列缺**堪治；眵眵③冷泪，**临泣**尤准。

髓骨将腿疼以祛残，**肾俞**把腰疼而泻尽。以见越人治尸厥④于**维会**，随手而苏；文伯泻死胎于**阴交**，应针而陨。

圣人于是察麻与痛，分实与虚。实则自外而入也，虚则自内而出欤。故济母而补其不足，夺子而平其有余。观二十七之经络，一一明辨；据四百四之疾证，件件皆除。故得天枉都无，跻⑤斯民于寿域；幾微已判，彰往古之玄书。

抑又闻心胸病，求掌后之**大陵**；肩背患，责肘前之**三里**。冷痹肾败，取足阳明之土⑥；连脐腹痛，泻足少阴之水⑦。脊间心后者，针**中膻**而立痊；胁下肋边者，刺**阳陵**而即止。头项痛，拟**后溪**以安然；腰脚疼，在**委中**而已矣。夫用针之士，于此理苟能明焉，收祛邪之功，而在乎拈指。

【注释】

- ① 蠲：除去。
- ② 揆：掌握。
- ③ 眵眵：指眼角分泌物过多。
- ④ 尸厥：突然昏厥、人事不省的一种病证。
- ⑤ 跻：登。
- ⑥ 足阳明之土：指足三里穴。
- ⑦ 足少阴之水：指阴谷穴。

(4) 百 证 赋

《百证赋》首载于明代针灸医家高武的《针灸聚英》，其作者已无考。高武云：“不知谁氏所作，辞颇不及于《指微》、《标幽》。曰‘百证’者，宜其曲尽百般病证针刺也。”全赋共53句，1008字。虽称“百证”，实则93证。取穴共162个。是一篇临床上很有参考价值的针灸歌赋。

百证俞穴，再三用心。**卤会**连于**玉枕**，头风①疗以金针。**悬颅**、**颞厌**之中，偏头痛止；**强间**、**丰隆**之际，头痛难禁。

原夫面肿虚浮，须使**水沟**、**前顶**；耳聋气闭②，全凭**听会**、**翳风**。面上虫行③有验，**迎香**可取；耳中蝉噪有声，**听会**堪攻。

目眩兮**支正**、**飞扬**，目黄兮**阳纲**、**胆俞**。**攀睛**④攻**少泽**、**肝俞**之所，泪出刺**临泣**、**头维**之处。目中漠漠，即寻**攒竹**、**三间**；目觉眵眵⑤，急取**养老**、**天柱**。

观其雀目肝气，**睛明**、**行间**而细推；审他项强伤寒，**温溜**、**期门**而主之。**廉泉**、**中冲**，舌下肿疼堪取；**天府**、**合谷**，鼻中衄血宜追。**耳门**、**丝竹空**，住牙疼于顷刻；**颊车**、**地仓**穴，正口喎于片时。

喉痛兮，**液门**、**鱼际**云疗，**犊筋**兮，**金门**、**丘墟**来医。**阳谷**、**侠溪**，**颌肿**口噤并治；**少商**、**曲泽**，**血虚**口渴同施。**通天**去鼻内无闻之苦，**复溜**祛舌干口渴之悲。**哑门**、**关冲**，舌缓不活而要紧；**天鼎**、**间使**，失音啞嚅⑥而休迟。**太冲**泻唇喎以速愈，**承浆**泻牙疼而即移。项强多恶风，**束骨**相连于**天柱**；热病汗不出，**大都**更接于**经渠**。

且如两臂顽麻，**少海**就傍于**三里**；半身不遂，**阳陵**远达于**曲池**。**建里**、**内关**，扫尽胸中之苦闷；**听宫**、**脾俞**，祛残心下之悲凄。

久知肋肋疼痛，**气户**、**华盖**有灵；腹内肠鸣，**下脘**、**陷谷**能平。胸胁

支满⑦何疗，章门、不容细寻；膈疼饮蓄难禁，臆中、巨阙便针。胸满更加噎塞，中府、意舍所行；胸膈停留瘀血，肾俞、巨髃宜征。胸满项强，神藏、璇玑已试；背连腰痛，白环、委中曾经。脊强兮水道、筋缩，目眵⑧兮颧髅、大迎。瘕病⑨非颅息而不愈，脐风⑩须然谷而易醒。委阳、天池，腋肿针而速散；后溪、环跳，腿疼刺而即轻。梦魇⑪不宁，厉兑相谐于隐白；发狂奔走，上脘同起于神门。惊悸怔忡，取阳交、解溪勿误；反张悲哭，仗天冲、大横须精。癎疾必身柱、本神之令，发热仗少冲、曲池之津。岁热时行⑫，陶道复求肺俞理；风痫常发，神道还须心俞宁。湿寒湿热下髀定，厥寒厥热涌泉清。寒栗恶寒，二间疏通阴郄暗；烦心呕吐，幽门开彻玉堂明。行间、涌泉，主消渴之肾竭⑬；阴陵、水分，去水肿之脐盈。癆瘵传尸⑭，趋魄户、膏肓之路；中邪霍乱，寻阴谷、三里之程。治疸消黄，谿后溪、劳宫而看；倦言嗜卧，往通里、大钟而明。咳嗽连声，肺俞须迎天突穴；小便赤涩，兑端独泻太阳经⑮。刺长强于承山，善主肠风新下血；针三阴于气海，专司白浊久遗精。

且如臈俞、横骨，泻五淋之久积；阴郄、后溪，治盗汗之多出。脾虚谷以不消，脾俞、膀胱俞觅；胃冷食而难化，魂门、胃俞堪责。鼻痔必取龈交，瘕气须求浮白。大敦、照海，患寒疝而善弱；五里、臂臑，生癆瘵⑯而能治。至阴、屏翳，疗痒疾之疼多；肩髃、阳溪，消瘰风之热极。

抑又论妇人经事改常，自有地机、血海；女子少气漏血，不无交信、合阳。带下产崩，冲门、气冲宜审；月潮违限，天枢、水泉细详。膈并乳痛而极效，商丘痔瘤而最良。脱肛趋百会、尾翳⑰之所，无子搜阴交、石关之乡。中脘主于积痢，外丘收乎大肠。寒疟兮商阳、太溪验，瘕瘕⑱兮冲门、血海强。

夫医乃人之司命，非志士而莫为；针乃理之渊微，须至人之指教。先究其病源，后攻其穴道。随手见功，应针取效。方知玄里之玄，始达妙中之妙。此篇不尽，略举其要。

【注释】

① 头风：头痛时发时止，作止无常者称头风。

- ② 耳聋气闭：指暴气上逆所致之耳聋。
- ③ 面上虫行：指面部皮肤痒麻，如有虫爬行的感觉。多为血热所致。
- ④ 攀睛：即胬肉攀睛。
- ⑤ 漠漠、眊眊：均指两目模糊，视物不清。
- ⑥ 嚤嚤：形容语言不清、想说话而又说不出话的样子。
- ⑦ 胸胁支满：即胸胁支撑胀满。
- ⑧ 目瞬：即眼睑瞬动。
- ⑨ 瘛病：指以瘛挛抽搐、角弓反张为主症的一类疾病，多由高热而引起。
- ⑩ 脐风：即新生儿破伤风。
- ⑪ 魇：恶梦。
- ⑫ 岁热时行：指有季节性的温热病。
- ⑬ 肾竭：即消渴病中的下消病。
- ⑭ 癆瘵传尸：即结核病。
- ⑮ 太阳经：指小海穴。
- ⑯ 癰疮：即瘰癧。
- ⑰ 尾翳：鸠尾穴的别名。
- ⑱ 瘰癧：瘰，在脐的两旁有条状筋块突起，状如弓弦。癧，指两胁部有积块，平时隐没不见，痛时方能触得。

(5) 玉 龙 赋

《玉龙赋》最早见于明代针灸医家高武的《针灸聚英》，撰者未详。实际上该赋是在《玉龙歌》的基础上加以缩写而成，内容简洁，颇便诵习。高武按语云：“俗以《玉龙歌》为扁鹊所撰，盖后人之依托为之者。《玉龙赋》又总辑其要旨尔。”全赋共41句，712字，列95证，载穴120个。

夫参博以为要，辑简而舍繁。总玉龙以成赋，信金针以获安。

原夫卒暴中风，**顶门、百会**；脚气连延，**里、绝、三交**。头风鼻渊，**上星**可用；耳聾腮肿，**听会**偏高。**攒竹、头维**，治目疼头痛；**乳根、俞府**，疗气嗽痰哮。**风市、阴市**，驱腿脚之乏力；**阴陵、阳陵**，除膝肿之难熬。**二白**医痔漏，**间使**剿疟疾；**大敦**去疝气，**膏肓**补虚劳。**天井**治瘰癧瘰疹，**神门**治呆痴笑咷。

咳嗽风痰，**太渊、列缺**宜刺；**炅羸**①喘促，**璇玑、气海**当知。**期门、大敦**，能治坚痙疝气；**劳宫、大陵**，可疗心闷疮痍。心悸虚烦刺**三里**，时疫痙症②寻**后溪**。**绝骨、三里、阴交**，脚气宜此；**睛明、太阳、鱼尾**，目疾凭兹。老者便多，**命门**兼**肾俞**而着艾；妇女乳肿，**少泽**与**太阳**之可推。身柱腧嗽，能除臂痛；**至阳**却疸，善治神疲。**长强、承山**，灸痔最妙；**丰隆、肺俞**，痰嗽称奇。**风门**主伤冒寒邪之嗽，**天枢**理感患脾泄之危。**风池、绝骨**，而疗乎伛偻③；**人中、曲池**，可疗其痿伛④。**期门**刺伤寒未解，经不再传；**鸱尾**针癫痫已发，慎其妄施。**阴交、水分、三里**，蛊胀宜刺；**商丘、解溪、丘墟**，脚痛堪追。**尺泽**理筋急之不用，**腕骨**疗手腕之难移。肩脊痛兮，**五枢**兼于**背脊**；肘挛疼兮，**尺泽**合于**曲池**。风湿传于两肩，**肩髃**可疗；壅热盛于三焦，**关冲**最宜。手臂红肿，**中渚、液门**要辨；脾虚黄疸，**腕骨、中腕**何疑。伤寒有汗，攻**复溜**宜泻；伤寒有汗，取**合谷**当随。

欲调饱满之气逆，**三里**可胜；要起六脉之沉匿，**复溜**称神。**照海、支沟**，通大便之秘；**内庭、临泣**，理小腹之胀⑤。**天突、膻中**医喘嗽，**地仓、颊车**疗口喎。**迎香**攻鼻塞为最，**肩井**除臂痛如拿。**二间**治牙疼，**中魁**理翻胃而即愈；**百劳**止虚汗，**通里**疗心惊而即瘥。

大、小骨空，治眼烂能止冷泪；**左、右太阳**，医目疼善除血翳。**心俞、肾俞**，治腰肾虚乏之梦遗；**人中、委中**，除腰脊痛闪之难制。**太溪、昆仑、申脉**，最疗足肿之逆⑥；**涌泉、关元、丰隆**，为治尸劳之例。

印堂治其惊搐，**神庭**理乎头风。**大陵、人中**频泻，口气全除；**带脉、关元**多灸，肾败堪攻。腿脚重痛，针**髌骨、膝关、膝眼**；行步艰楚，刺**三里、中封、太冲**。取**内关**于**照海**，医腹疾之块；搐**迎香**于鼻内，消眼热之红。肚疼秘结，**大陵**合**外关**于**支沟**；腿风湿痛，**居髎**兼**环跳**于**委中**。**上腕、中腕**，治九种之心痛；赤带、白带，求**中极**之异同。

又若心虚热壅，少冲明于济夺；目昏血溢，肝俞辨其实虚。当心传之玄要，究手法之疾徐。或值挫闪疼痛之不足，此为难拟定穴之可祛。辑管见以便诵读，幸高明而无哂譏。

【注释】

- ① 尪羸：极度瘦弱。
- ② 痼症：指两日一发的疟疾。
- ③ 伛偻：驼背。
- ④ 痿伛：肌肉萎弱无力，脊背弯曲的病证。
- ⑤ 臌：腹胀。
- ⑥ 迟：行动迟缓。

(6) 胜 玉 歌

《胜玉歌》为明代医家杨继洲家传针灸经验的总结，载于《针灸大成》中。歌名“胜玉”，是指其内容胜过王国瑞所撰之《玉龙歌》而言。《玉龙歌》因其内容丰富，取穴精简，流传甚广。后人更撮其精要而缩写成《玉龙赋》。而杨继洲将此歌取名“胜玉”，强调了其内容的重要，临床亦颇具参考价值。全歌共532字。列56证。歌诀末虽有“六十六穴施应验，故成歌诀显针奇”一句，但实际取穴为55个。

胜玉歌今不虚言，此是杨家真秘传。或针或灸依法语，补泻迎随随手拈。

头痛、眩晕百会好，心疼、脾痛上脘先。后溪、鸠尾及神门，治疗五痛立便痊。脾疼要针膈井穴，耳闭①听会莫迟延。胃冷下脘却为良，眼痛须觅清冷渊。

霍乱、心疼吐痰涎，巨阙着艾便安然。脾疼、背痛中渚泻，头风、眼痛上星专。

头项强急承浆保，牙腮疼紧大迎全。行间可治膝肿病，尺泽能医筋

拘挛。

若人行步苦艰难，中封、太冲针便痊。脚背痛时商丘刺，瘰癧②少海、天井边。腹疼、闭结③支沟穴，颌肿、喉闭少商前。脾心痛急寻公孙，委中驱疗脚风缠。

泻却人中及颊车，治疗中风口吐沫。五疟寒多热更多，间使、大杼真妙穴。经年或变劳怯④者，落满脐旁章门决。噎气吞酸食不投，腹中七壮除膈热。

目内红痛苦皱眉，丝竹、攒竹亦堪医。若是痰涎并咳嗽，治却须当灸肺俞。更有天突与筋缩，小儿吼闭⑤自然疏。两手酸疼难执物，曲池、合谷共磨髑。臂疼、背痛针三里，头风、头痛灸风池。肠鸣大便时泄泻，脐旁两寸灸天枢。

诸般气证从何治，气海针之灸亦宜。小肠气痛归来治，腰痛中空穴最奇。

腿股转酸难移步，妙穴说与后人知。环跳、风市及阴市，泻却金针病自除。

热疮膝内⑥年年发，血海寻来可治之。两膝无端肿如斗，膝眼、三里艾当施。两股转筋承山刺，脚气复溜不须疑。踝跟骨痛灸昆仑，更有绝骨共丘墟，灸罢大敦除疝气，阴交针入下胎衣。

遗精、白浊心俞治，心热、口臭大陵驱。腹胀水分多得力，黄疸至阳便能离。肝血盛兮肝俞泻，痔疾肠风长强欺。肾败⑦腰疼小便频，肾脉两旁肾俞除。六十六穴施应验，故成歌诀显针奇。

【注释】

- ① 耳闭：指由气逆而引起的暴聾。
- ② 瘰癧：即淋巴结核。
- ③ 闭结：指大便闭结。
- ④ 劳怯：指各种虚劳病证。
- ⑤ 吼闭：吼，指哮喘。闭，指牙关紧闭。
- ⑥ 膝内：指小腿内侧。
- ⑦ 肾败：即肾气虚弱，阳气不足。